

KOŃCOWY MODEL ROZWIĄZANIA „GO AHEAD – MÓW ŚMIAŁO”

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Dostępności” – Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spis treści

WSTĘP	3
1. OPIS GRUPY DOCELOWEJ I ODBIORCÓW ROZWIĄZANIA	4
1.1 SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE	6
1.2 METODY ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	8
1.3 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA- DEFINICJA I KLASYFIKACJA	10
1.4 CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ:	10
1.5 PROCESY UMYSŁOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	12
1.6 USPRAWNIANIE ZABURZONYCH FUNKCI UMYSŁOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	18
2. KOMUNIKACJA, JĘZYK I MOWA	27
3. OPIS ROZWIĄZANIA I JEGO FUNKCJONALNOŚCI	34
4. PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY	42
5. NARZĘDZIA MONITORUJĄCE POSTĘPY UCZESTNIKÓW	44
6. SCENARIUSZE ZAJĘĆ	47
Scenariusz zajęć nr 1: Temat: Dbam o zdrowie - HIGIENA OSOBISTA	47
Scenariusz zajęć nr 2: Temat: BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY	57
Scenariusz zajęć nr 3 Temat zajęć: PIERWSZA POMOC PRZY OPARZENIU	68
Scenariusz zajęć nr 4 :Temat: WIZYTA U LEKARZA.	75
Scenariusz zajęć nr 5: Temat: ZAKUPY	90
7. WYNIKI TESTÓW, REKOMENDACJE I ZALECENIA DLA PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW	101
8. PODSUMOWANIE.	105

WSTĘP

„GO AHEAD – mów śmiało” to narzędzie (aplikacja) służące rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Umiejętności te są uznane za jedno z niezbędnych zarówno do nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych z innym jak również nabywanie kompetencji społecznych warunkujących podjęcie niezależnego życia, stosownie do możliwości psychofizycznych. Usprawniona dzięki aplikacji komunikacja korzystnie wpłynie też na proces uczenia i rozwijania umiejętności samoobsługowych Beneficjentów potrzebnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i funkcjonowania w środowisku.

„Człowiek, który postępuje niezależnie, który angażuje swoje siły w wykonanie zadań, pokonuje sam siebie, doskonali się i rozwija swoje zdolności”

/Maria Montessori/

1. Opis grupy docelowej i odbiorców rozwiązania

Adresatami zajęć testujących Innowację są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy.

Realizatorami Programu są oligofrenopedagodzy, instruktorzy terapii zajęciowej przygotowani do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe podopiecznych. Dla potrzeb realizacji programu w ramach projektu została opracowana koncepcja oraz program szkolenia realizatorów dotyczący wykorzystywania aplikacji przygotowanej w ramach Innowacji.

Samodzielność i niezależność jest potrzebą rozwojową każdego człowieka. Dotyczy zarówno osób zdrowych jak i osób z niepełnosprawnością, niezależnie od jej rodzaju, także osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obejmuje nie tylko umiejętności radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobsługowych. To przede wszystkim autonomia i gotowość do podejmowania wyzwań i pokonywania różnych przeszkód, gotowość do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, której źródłem jest wola działania osoby z niepełnosprawnością.

Daje ona poczucie niezależności, samodzielności oraz pełni życia. Aby była możliwa, osoba z niepełnosprawnością musi być wyposażona w umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na aktywność w różnych sferach życia.

Do dorosłości przygotowujemy się stopniowo, w procesie edukacji, wychowania, obserwacji oraz poprzez podejmowanie prób i gromadzenie doświadczeń. Od dzieciństwa stopniowo opanowujemy umiejętności niezbędne do niezależnego życia, rozwijamy swoje możliwości, poznajemy własną odrębność i kształtujemy własną tożsamość. Niezależność może przejawiać się w możliwości organizacji swojej pracy, podejmowaniu samodzielnych decyzji, nowych wyzwań, w gotowości do nabywania nowych kompetencji, własnego rozwoju. Ważna jest też gotowość do współdziałania i współpracy.

Niezwykle ważna jest tu rola rodziców i otoczenia, które samodzielność dziecka może rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić. Rodzice nadmiernie chronią dziecko, czasami odbierają mu możliwość stania się samodzielną i niezależną osobą. Nie dają mu szansy rozwoju i uczenia się na własnych błędach. Dziecko nabiera wówczas przekonania, że rodzice nie wierzą w jego możliwości, a ono samo do niczego się nie nadaje.

W szczególnej sytuacji znajduje się otoczenie osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną. Rodzicom dziecka z niepełnosprawnością nie jest łatwo podążać drogą wiodącą do jego autonomii. Przyzwyczajeni do stałego czuwania przy dziecku, troski, a czasem walki o jego zdrowie, bezpieczeństwo i lepszą jakość życia, często nie zauważają jego potrzeby odrębności i decyzyjności. Wyręczając dziecko we wszystkim pozbawiają je radości z pierwszych odkryć i sukcesów, a przede wszystkim ograniczają lub opóźniają jego potencjalny rozwój, na miarę możliwości psychofizycznych. Wskutek tego dorosłe osoby z niepełnosprawnością często są nieporadne, niesamodzielne i zależne od swoich najbliższych. Nie potrafią zatroszczyć się o siebie i swoje sprawy. Nie uczestniczą w życiu swojego otoczenia, nie pracują – żyją „obok społeczeństwa”. Przyzwyczajenie do stałego instruowania i programowania ich aktywności przez dorosłych procentuje dodatkową bezradnością i uzależnieniem od innych. Zamiast tego osoba z niepełnosprawnością potrzebuje szczególnego wsparcia i pomocy, odpowiedniej zachęty ze strony otoczenia w kształtowaniu kompetencji społecznych oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia niezależnego życia.

Ważnymi obszarami warunkującymi samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną, o które powinni zadbać ich opiekunowie, są umiejętności samoobsługowe i komunikacyjne, które wpływają na wszystkie inne obszary funkcjonowania, w tym działanie w świecie zewnętrznym, ciekawość poznawczą, nawiązywanie i podtrzymywanie satysfakcjonujących relacji społecznych.

Istotnym aspektem takiego wsparcia jest zapewnienie odpowiednich narzędzi, pomocy oraz metod pracy dostosowanych do szczególnych potrzeb edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami i zapewnienie warunków do kształtowania i trenowania samodzielności.

Aktualnie w obszarze usprawniania i aktywizowania osób z niepełnosprawnością intelektualną brak jest efektywnych, interaktywnych narzędzi rozwijających ich umiejętności i kompetencje komunikacyjne. Rolę taką może pełnić Innowacja „GO AHEAD – mów śmiało”, która nastawiona jest na kształtowanie tych umiejętności, co zwiększy szanse życiowe dorosłych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawni ich aktywność społeczną i zawodową. Przyczyni się do zniwelowania poczucia wykluczenia społecznego.

Narzędzie - oprogramowanie tematyczne, opracowane w ramach Innowacji „GO AHEAD – mów śmiało” umożliwi interaktywne nauczanie wielozmysłowe, poszerzenie zakresu umiejętności samoobsługowych i kompetencji pozwalających na samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej, co korzystnie wpłynie na ich poczucie własnej wartości i sprawczości. W aspekcie społecznym samodzielność zwiększona dzięki korzystaniu z narzędzia przełoży się na zmniejszenie zakresu niezbędnego wsparcia osób innych i odciążeniu rodziców i opiekunów.

1.1 SAMODZIELNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Proces rozwoju samodzielności można rozpatrywać w trzech aspektach: samodzielności praktycznej, umysłowej i społecznej.

- Aspekt praktyczny dotyczy głównie czynności samoobsługowych, takie jak: korzystanie z toalety, mycie się, ubieranie i rozbieranie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, utrzymanie porządku, dbanie o siebie oraz o swoje otoczenie.
- Aspekt umysłowy polega na umiejętności podejmowania wyborów oraz rozwiązywania problemów zarówno podczas nauki, realizacji zainteresowań, samodzielnym zdobywaniu doświadczeń, wyrażaniu swoich opinii, pokonywaniu przeszkód. Dzięki rozwojowi tych umiejętności człowiek nabywa umiejętności niezbędne do pokonywania trudności życiowych, do rozwoju woli działania, podejmowania ważnych decyzji życiowych oraz budowania własnego kodeksu etycznego i hierarchii wartości.

- Samodzielność społeczna przejawia się w swobodzie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, wysoko rozwiniętą umiejętnością współdziałania i pracy w zespole, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, czy negocjacji. Osoby z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami społecznymi w dorosłym życiu nie mają zazwyczaj problemów z wypełnianiem przypisanych im ról społecznych.

Opisane powyżej aspekty samodzielności ukazują jak ważną rolę odgrywa ona w życiu każdego człowieka. Wpływa na jego jakość, pozwala zaspokoić potrzeby, realizować swoje pasje i marzenia oraz odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Dorośła, w pełni ukształtowana osoba samodzielna to jednostka pewna siebie, którą cechuje poczucie bezpieczeństwa i wiara we własne możliwości. Taka osoba dobrze radzi sobie z wyzwaniami edukacyjnymi i zawodowymi, potrafi sprostać wymaganiom stawianym jej przez życie. Człowiek samodzielny to taki, który jest otwarty na nowe możliwości, ma zaufanie do swoich wyborów, jest gotowy na zmiany i wyzwania, nie boi się wypowiadać własnych opinii. Cechuje się twórczym sposobem myślenia, nie boi się ryzyka, jest świadomy konsekwencji swoich działań, także w nieznanej przyszłości i w sytuacjach trudnych, nieprzewidywanych. Dlatego w rozwijaniu samodzielności ważne jest kształtowanie elastyczności, kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji. Dzięki takim oddziaływaniom człowiek jest przygotowany na różne sytuacje i reaguje adekwatnie, zwiększając swoją zaradność życiową i niezależność od innych.

Na nabywanie kompetencji i umiejętności związanych z samodzielnością osób z niepełnosprawnością intelektualną składa się kilka czynników. Są to:

- otoczenie wychowawcze i terapeutyczne,
- kompetencje motoryczne, poznawczo-emocjonalne,
- liczba i charakter zgromadzonych doświadczeń.

Osoby z zaburzeniami rozwoju uczą się wolniej. Aby opanować nową umiejętność, wymagają odpowiednich metod nauczania, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, znacznie większej liczby powtórzeń danej czynności, niż osoby rozwijające się w sposób normatywny.

Musimy być jednak świadomi ograniczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną i stawiać przed nimi cele realne do osiągnięcia, na miarę ich możliwości psychofizycznych.

1.2 METODY ROZWIJANIA SAMODZIELNOŚCI U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, w zakresie rozwoju samodzielności, potrzebują dodatkowych oddziaływań, dostosowanych do specyficznych potrzeb, wynikających z charakteru ograniczeń. Podczas pracy z nimi najpierw należy przeprowadzić diagnozę funkcjonalną posiadanych umiejętności.

Głównymi umiejętnościami, które warunkują samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną są:

- komunikacja,
- umiejętności z zakresu rozwoju społecznego,
- samoobsługa (samodzielne korzystanie z toalety, czynności higieniczne, ubieranie się i rozbieranie, samodzielne przygotowywanie i jedzenie posiłków, samodzielne spędzanie czasu, realizacja czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego).

W tym celu wykorzystujemy różnorodne metody i techniki pracy, dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych osoby z niepełnosprawnością.

Pojęcie „specjalne potrzeby edukacyjne” po raz pierwszy użyto w opublikowanym w 1978 roku brytyjskim dokumencie rządowym zwanym Raportem Warnock (od nazwiska Helen Mary Warnock, przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Niepełnosprawnych Dzieci i Młodzieży). W dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. *Reforma Systemu Kształcenia Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi* (1998) terminem „specjalne potrzeby edukacyjne” określa się „potrzeby osób (dzieci i młodzieży doświadczających trudności w uczeniu się, wynikające z ich niepełnosprawności lub innych przyczyn”.

W trakcie uczenia nowych i deficytowych umiejętności należy wybrać najbardziej skuteczną w pracy z daną osobą strategię nauczania. Korzystne jest w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju stosowanie wizualnych pomocy, które są dla nich bardziej zrozumiałe. Pedagogika specjalna wyróżnia tu:

- modelowanie, czyli prezentację wykonania czynności, której uczymy. Poprzez obserwację i naśladowanie osoby prezentującej, osoby z niepełnosprawnością przyswajają sobie właściwe schematy działania. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie samodzielnie powtórzyć wykonywanych czynności, powinniśmy zastosować pomoc fizyczną. Polega ona na poruszaniu konkretnej części ciała osoby z niepełnosprawnością w celu wykonania przez nią danej czynności np. mycia rąk, czy jedzenia posiłków.
- podpowiedzi modelujące i fizyczne, podpowiedzi werbalne oraz wskazujące,
- podpowiedzi werbalne (słowne) służą do modelowania poprawnej wypowiedzi lub przypomnienia o zadaniu, które miało być wykonane,
- podpowiedź wskazująca polega na wskazaniu przez terapeutę przedmiotu potrzebnego do wykonania danej czynności (np. szczoteczki do zębów podczas mycia zębów, mydła itp.).
- stopniowe zmierzanie *do celu przez stosowanie wzmocnień* - Rozwijając samodzielność dziecka możemy również korzystać z procedury kształtowania, w której stopniowo zmierzamy do celu, czyli uczenia zachowania lub kształtowania umiejętności, które chcemy uzyskać. Polega ono na dostarczaniu wzmocnień dla zachowań coraz bardziej zbliżonych do zachowania docelowego. Wzmocnieniem może być np. ulubiona aktywność, smakołyk lub pochwała. Technika rozwoju umiejętności samoobsługowych w pedagogice specjalnej jest też - nauka poprzez łańcuch zachowań - Podczas stosowania tej procedury dzielimy uczoną przez nas czynność na mniejsze sekwencje. Naukę zaczynamy od nauczania jednej z nich (pierwszej lub ostatniej). Po osiągnięciu danej sekwencji przechodzimy do kolejnej. Naukę kończymy w momencie, kiedy osoba ucząca się samodzielnie wykonuje całą czynność,

- komunikacja wspomagająca lub alternatywna - do wspomagania rozwoju mowy i komunikacji wykorzystuje się pomoce w postaci symboli obrazkowych, zdjęć czy gestów. Z ich pomocą osoba z niepełnosprawnością wyraża swoje potrzeby, emocje oraz komentuje sytuacje z otoczenia.

1.3 NIEPEŁENOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA- DEFINICJA I KLASYFIKACJA

Według klasyfikacji ICD10, upośledzenie umysłowe to stan zahamowania lub niepełnego rozwoju umysłu, który charakteryzuje się statystycznie istotnym obniżeniem ogólnej sprawności intelektualnej w porównaniu z wartością przeciętną ($IQ < 70$) – w tym zdolności: poznawczych, komunikacyjnych, ruchowych i społecznych.

Klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej w zależności od głębokości upośledzenia:

- Upośledzenie lekkie ($IQ: 50 - 69$)
- Upośledzenie umiarkowane ($IQ: 35 - 49$)
- Upośledzenie znaczne ($IQ: 20 - 34$)
- Upośledzenie głębokie ($IQ < 20$)

Upośledzenie powoduje obniżenie funkcjonowania przystosowawczego w różnych obszarach życia, pogłębiające się wraz z głębokością upośledzenia. Wpływa na ograniczenie zdolności osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, zaspokajania własnych potrzeb, prowadzenia gospodarstwa domowego, nawiązywania kontaktów interpersonalnych na płaszczyźnie społecznej, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, uczenia się i organizacji czasu wolnego.

1.4 CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA OSÓB Z NIEPEŁENOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ:

- Upośledzenie lekkie ($IQ 50 - 69$):

- pełna niezależność w samoobsłudze (jedzenie mycie się, ubieranie, kontrola zwieraczy), praktycznych i domowych czynnościach,
 - trudności w uczeniu się, wykorzystywaniu podstawowych technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) – pomocne są specjalnie profilowane programy nauczania,
 - potencjalna zdolność do pracy wymagającej praktycznych umiejętności.
- Upośledzenie umiarkowane (IQ 35 - 49)
- Ograniczona umiejętność posługiwania się mową,
 - upośledzenie w zakresie samoobsługi i grafomotoryki,
 - bardzo duże ograniczenia nabywania wiedzy i umiejętności (tylko część osób z upośledzeniem umiarkowanym jest w stanie opanować, w zakresie podstawowym, czytanie, pisanie i liczenie)
 - potencjalna zdolność do wykonywania prostych, praktycznych prac pod nadzorem opiekuna
 - całkowita niezależność w dorosłym życiu to rzadkość,
 - zdolność do nawiązywania kontaktu, porozumiewania się i angażowania w proste społeczne działania i relacje.
- Upośledzenie znaczne (IQ 20 - 34)
- podobieństwo w zakresie obrazu klinicznego do upośledzenia umiarkowanego,
 - niższy poziom osiągnięć w zakresie edukacji i zaradności życiowej,
 - częste współistnienie uszkodzenia aparatu ruchowego i innych deficytów neurologicznych
 - wymaga nadzoru i kontrolowanego środowiska
- Upośledzenie głębokie (IQ < 20)
- poważne trudności w rozumieniu i spełnianiu poleceń lub instrukcji
 - brak zdolności do dbania o swoje własne podstawowe potrzeby
 - wymagają stałej pomocy i nadzoru
 - duże deficyty neurologiczne i fizyczne.

1.5 PROCESY UMYŚŁOWE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

MYŚLENIE

Myślenie osób z niepełnosprawnością umysłową cechuje:

- spowolnienie tempa myślenia,
- obniżony krytycyzm,
- występowanie trudności w definiowaniu pojęć abstrakcyjnych,
- występowanie trudności we wnioskowaniu i abstrahowaniu,
- niska płynność myślenia (mniejsza wyobraźnia),
- niedostateczny poziom przyswajania reguł i zasad,
- utrudnienia w zakresie zdolności analizy i syntezy,
- upośledzenie wnioskowania, myślenia indukcyjnego oraz wnioskowania przez analogię,
- osłabiona regulacyjna rola myślenia,
- preferowanie poznania bezpośredniego, z zastosowaniem działań konkretnych, doświadczeń i obserwacji (charakter konkretno obrazowy myślenia).

U niektórych osób z niepełnosprawnością intelektualną występuje zdolność do szeregowania, klasyfikowania, przyporządkowywania, dodawania, mnożenia w odwołaniu do przedmiotów.

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA

Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną cechuje:

- utrudnione przystosowanie społeczne,
- trudności w zakresie zdolności empatycznych, zdolności wczuwania się w sytuację innej osoby, spostrzegania społecznego,
- słabo rozwinięte umiejętności komunikowania się,

- zaburzenia rozwoju moralnego,
- niewłaściwe odczytywanie (rozumienie) sygnałów społecznych;
- brak krytycyzmu, infantylizm, łatwowierność.

UWAGA I PAMIĘĆ

U osób z niepełnosprawnością intelektualną uwaga dowolna na materiale konkretnym jest zazwyczaj prawidłowa, a na materiale abstrakcyjnym – ograniczona, Dominuje uwaga mimowolna nad dowolną. Koncentrację uwagi przyciągają bodźce wyraziste, intensywne. Często występują zaburzenia uwagi na bodźcach znaczących i mała podzielność uwagi.

Pamięć to proces zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania otrzymanych informacji. U osób z niepełnosprawnością intelektualną dominuje dobra pamięć mechaniczna. Osłabiona jest pamięć logiczna i dowolna. Wpływa to na słabe tempo uczenia się, uczenie się bez zrozumienia, wolne tempo zapamiętywania, ograniczoną pojemność pamięci. Zdolność do przechowywania w pamięci spostrzeżeń i zjawisk jest osłabiona i powoduje mniejszą gotowość do ich odtwarzania, powolniejsze tempo przyswajania zasad i norm, oraz klasyfikacji pojęć.

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim: Dobra pamięć mechaniczna, zdarzają się przypadki wybitnie dobrej pamięci fotograficznej. Słaba pamięć logiczna i dowolna. Wolne tempo uczenia. Uczenie się bez zrozumienia. Zdolność zapamiętywania piosenek i wierszy.

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: Podobnie jak w upośledzeniu lekkim dobra pamięć mechaniczna, zdarzają się przypadki wybitnie dobrej pamięci fotograficznej. Ograniczony zakres pamięci. Bardzo wolne tempo uczenia się. Potrafi zapamiętać proste piosenki i wiersze.

Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: Zapamiętywanie znacznie utrudnione. Zakres pamięci znikomy, mała trwałość pamięci. Potrafi zapamiętać najprostsze układy ruchowe.

Osoby dorosłe z upośledzeniem głębokim potrafią powtórzyć zdanie, zapamiętać i wykonać proste polecenia.

Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim: Zapamiętywanie i uczenie się są zniesione lub widoczne jedynie w opanowywaniu prostych reakcji ruchowych np. odszukiwanie schowanego przedmiotu, rozpoznawanie bliskich osób.

MOTYWACJA I FUNKCJONOWANIE EMOCJONALNE

U osób z niepełnosprawnością intelektualną motywację do uczenia się i aktywności cechuje: zwolnione tempo pracy, brak samodzielności, pomysłowości i przemyślanego działania. Wymagają wsparcia, gdyż w chwilach trudności załamują się. Korzystnie na ich funkcjonowanie wpływają bodźce do pracy w postaci pochwały, zachęty, nagrody, a czasem wyraźnego polecenia (rozkazu).

W sferze funkcjonowania emocjonalnego występuje osłabiona kontrola emocji, popędów, dążeń, zdolności do uczuć wyższych, niedojrzałość emocjonalna, nadmierna pobudliwość, nieadekwatność reakcji emocjonalnych i tendencja do obniżonego samopoczucia w przypadku niepowodzenia.

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim: Osłabiona kontrola emocji, popędów, dążeń. Zachowana zdolność do uczuć wyższych. Utrudnione przystosowanie społeczne. Niektóre osoby z upośledzeniem lekkim osiągają wysoki stopień uspołecznienia.

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym:

Osoba ujawnia wrażliwość emocjonalną, głębokie przywiązanie się do osób bliskich. Słabo kontroluje emocje, popędy i dążenia.

Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym:

Osoby z upośledzeniem znacznym są zdolne do okazywania uczuć, przywiązania, choć wyrażają je w sposób infantylny. Często nie kontrolują emocji i popędów. Są mało

samodzielne, czasami realizują swoje proste potrzeby, zazwyczaj nie potrafią zadbać samodzielnie o higienę osobistą.

Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim:

Osoby z upośledzeniem głębokim są zdolne do wyrażania prostych emocji. Najczęściej brak objawów życia uczuciowego i przejawów samodzielności. W wyniku długotrwałego ćwiczenia można nauczyć je sygnalizowania potrzeb fizjologicznych.

SPOSTRZEGANIE

Sprawność percepcji wzrokowej jest uzależniona od stopnia upośledzenia. Zaburzenie tej funkcji powoduje trudności z wyróżnieniem istotnych szczegółów w spostrzeganym materiale:

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim: Sprawność spostrzegania zasadniczo w normie. Mogą jednak występować zaburzenia: wolny tok spostrzegania, trudności z wyróżnieniem istotnych szczegółów lub spostrzeżenia nieprecyzyjne.

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: Obniżona sprawność spostrzegania. Spostrzega cechy konkretne, nie odróżnia cech ważnych.

Upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: Znacznie obniżona sprawność i szybkość spostrzegania. Spostrzeżenia niedokładne. Trudności w rozpoznawaniu przedmiotów, wyodrębnianiu elementów całości.

Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim: Głęboko zaburzona sprawność spostrzegania. Reakcje głównie na bodźce sygnalizujące pokarm lub obecność osób bliskich. Czasami nie udaje się wywołać koncentracji wzroku na przedmiocie.

SPRAWNOŚĆ SENSORYCZNA: WRAŻLIWOŚĆ SŁUCHOWA

Sprawność sensoryczna, wrażliwość słuchowa u osób z niepełnosprawnością intelektualną jest uzależniona od sprawności ośrodkowego układu nerwowego, od którego

zależy różnicowanie dźwięków, ich analiza i synteza. Jeżeli ośrodek słuchowy kory mózgowej jest uszkodzony lub mniej sprawny, proces różnicowania, analizowania i syntezy dźwięków jest zaburzony. Może się zdarzyć, że osoby z zaburzeniami percepcji słuchowej poszczególne dźwięki słyszą bardzo dobrze, bez względu na odległość, lecz nie potrafią ich różnicować, analizować czy też dokonywać ich syntezy. Zaburzenia percepcji słuchowej u osób z upośledzeniem w stopniu znacznym utrudniają opanowanie umiejętności czytania i pisanie. Zaburzenia percepcji słuchowej mogą występować z różnym nasileniem u osób z niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od stopnia upośledzenia.

MOWA

U osób z niepełnosprawnością intelektualną często występują trudności z formułowaniem myśli i wypowiedzi, agramatyzmy, mały zasób słów i pojęć, częste wady wymowy.

MOTORYKA, SPRAWNOŚĆ RUCHOWA

W zakresie ogólnego rozwoju ruchowego (motoryka duża) u osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą wystąpić opóźnienia lub zaburzenia w rozwoju ruchowym, mała aktywność ruchowa, ogólna niezręczność ruchowa i mała wyćwiczalność w zakresie dużych ruchów związana z zakłóceniami napięcia mięśniowego. Wrażenie ogólnej niezręczności może wynikać z braku koordynacji ruchów przy współdziałaniu różnych grup mięśniowych.

Może się to przejawiać w:

- osiągnięciu z opóźnieniem różnych umiejętności ruchowych w czynnościach codziennych,
- ogólnym spowolnieniu ruchowym,
- trudności w wykonywaniu ruchów precyzyjnych.
- nasilonej męczliwości,
- trudnościach w wykonywaniu ruchów równoczesnych,
- unikaniu zajęć ruchowych,

- zakłóceniach koordynacji wzrokowo-ruchowej w czynnościach i zadaniach, w których ruch odbywa się pod kontrolą wzorku oraz w naśladowaniu demonstrowanego ruchu.

Zakłócenia motoryki manualnej (motoryka mała, grafomotoryka) mogą występować na tle ogólnej niesprawności ruchowej lub mogą być zaburzeniem izolowanym.

Do objawów zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej na tym tle należy zaliczyć:

- opóźnienia w rozwoju praktyki,
- małą wyćwiczalność w zakresie ruchów drobnych, związaną z nadmiernym lub za małym napięciem mięśni oraz brakiem koordynacji ruchów palców, dłoni i przedramienia,
- zakłócenia koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku,
- niedostosowanie szybkości ruchów rąk do wykonywanej czynności,
- unikanie podejmowania czynności manualnych.

Czynności wymagające koordynacji wzrokowo-ruchowej mogą być dezorganizowane i wynikać także z zakłóceń w spostrzeganiu wzrokowym. Mogą mieć formę:

- trudności w wyodrębnianiu części w złożonej całości oraz w scalaniu poszczególnych części w całość,
- trudności w dostrzeganiu różnic pomiędzy podobnymi przedmiotami, obrazami i układami przestrzennymi oraz podobieństw w układach pozornie całkowicie różnych,
- trudności w odwzorowywaniu graficznym i przestrzennym złożonych struktur, przede wszystkim o charakterze abstrakcyjnym,
- trudności w rozumieniu i wnioskowaniu na materiale obrazowym.

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej mogą występować z różnym nasileniem u osób upośledzonych, niezależnie od stopnia upośledzenia.

SPRAWNOŚĆ GRAFICZNA

Sprawność graficzna uzależniona jest od precyzji ruchów palców i dłoni oraz zdolności regulowania napięcia mięśni, w zależności od wykonywanych czynności. Ta tzw. „mała motoryka” umożliwia pisanie, zapinanie guzików i wykonywanie innych ruchów drobnych.

Warunkuje też wykonywanie czynności samoobsługowych.

Zaburzenia sprawności graficznej są częstą dysfunkcją u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stopień zaburzenia sprawności graficznej pogłębia się w większości wraz ze stopniem upośledzenia.

Do ważniejszych zaburzeń małej motoryki, zaliczyć można:

- opóźnienia w rozwoju praktyki (umiejętności posługiwania się przedmiotami codziennego użytku)
- brak precyzji ruchów związanych z nadmiernym lub za małym napięciem mięśni oraz z brakiem koordynacji ruchów palców, dłoni i przedramienia
- zakłócenia koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod kontrolą wzroku (niski poziom graficzny oraz trudności w zajęciach plastycznych)
- szybkość ruchów rąk niedostosowaną do wykonywanych czynności,
- niechęć do podejmowania czynności graficznych.

1.6 USPRAWNIANIE ZABURZONYCH FUNKCI UMYSŁOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

MOWA, ZDOLNOŚĆ KOMUNIKOWANIA SIĘ Z INNYMI:

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- posługiwanie się prostymi wypowiedziami,
- stosowanie pojęć znanych uczniom,
- definiowanie pojęć nieznanymi bądź znanych pobieżnie,
- prezentowanie instrukcji wykonania danej czynności w postaci jasnych, zrozumiałych

komunikatów,

- używanie instrukcji nie tylko słownych, lecz: obrazkowych, pisemnych, pisemno-obrazkowych.

MYŚLENIE:

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- stosowanie metod słownych: instrukcji, charakterystyki sytuacji, wykorzystywanie przekazów multimedialnych, filmów, obrazków, bezpośredniego pokazu,
- stosowanie prezentacji z wykorzystaniem konkretnych materiałów, sprzętu, narzędzi,
- dzielenie działania na etapy, części, każdy etap silnie zaznaczony, wyodrębniony spośród całości,
- przedstawianie różnorodnych sytuacji, zagrożeń,
- stosowanie technik ułatwiających transfer wiadomości (wykorzystywanie pomysłów uczestników zajęć, motywowanie do tworzenia pomysłów),
- oferowanie wydłużonego czasu na pokaz i ćwiczenie konkretnych umiejętności,
- wyjaśnianie pojęć nie znanych, ze szczególnym „zatrzymaniem” na cechach istotnych,
- korzystanie z metod rozwiązywania problemów, metod aktywizujących (gier i zabaw dydaktycznych, symulacji),
- rozwijanie umiejętności szeregowania, klasyfikowania, porządkowania,
- dążenie do maksymalnego posługiwania się schematami ułatwiającymi zapamiętanie i wykorzystywanie wiedzy w odpowiednim momencie,
- wykorzystywanie technik mnemotechnicznych oraz atrakcyjnych zabaw dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie,
- stosowanie pogadanek przybliżających trudne sytuacje.

ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI UWAGI:

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- korzystanie z materiału konkretnego podczas prezentacji,
- pomysłowość w przedstawianiu elementów ważnych, istotnych dla zajęć w celu zwiększenia wyrazistości przekazu, atrakcyjności, która ułatwi koncentrowanie uwagi na

określonych bodźcach,

- dbanie o przerwy, relaks w chwilach utraty zdolności do koncentracji na materiale,
- stosowanie różnorodnych metod pracy,
- organizowanie zajęć w różnych formach.

SPRAWNOŚĆ PAMIĘCI:

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- wykorzystywanie technik ułatwiających zapamiętanie materiału,
- oznaczanie w sposób wyrazisty treści znaczących,
- dążenie do tworzenia schematów, ułatwiających „poruszanie” się w różnych sytuacjach,
- dbałość o dostarczanie podczas zajęć wyselekcjonowanego, określonego materiału „na temat”,
- dbałość o uporządkowanie materiału prezentowanego na zajęciach,
- częste i wielokrotnie powtarzanie ćwiczeń,
- stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy,
- nawiązywanie - np.: podawanie przykładów różnych sytuacji „z życia”, do wiedzy uczestników zajęć, do sytuacji znanych, przeżywanych lub zaobserwowanych.

Rozwijanie:

- zakresu pamięci – poszerzanie zakresu materiału, który może osoba zapamiętać,
- trwałości pamięci – zwiększenie poziomu przechowywania zapamiętanego materiału,
- wierności pamięci – tzn. zwiększenia dokładności materiału zapamiętywanego,
- gotowości pamięci – tzn. łatwości przypominania sobie opanowanego wcześniej materiału w danym momencie,
- szybkości zapamiętywania

MOTYWACJA

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- dbałość o określanie zawsze na początku zajęć oraz w każdej nadarzającej się sytuacji

celowości, przydatności poznanego materiału,

- tworzenie systemu motywacyjnego (konkursy, zdobywanie punktów, stopni),
- wykorzystywanie atrakcyjnych środków dydaktycznych, korzystanie z metod aktywizujących, metod problemowych,
- tworzenie miłej, pobudzającej do nauki atmosfery,
- zapewnianie o możliwości wsparcia, pomocy, rady,
- dbałość o samodzielność, aktywność uczestników na zajęciach,
- zawieranie umów-kontraktów – określenie regulaminu oraz systemu nagród i kar,
- motywowanie do działania, do podejmowania wysiłku, do kończenia pracy poprzez wszelkie formy zachęty, pochwały, słowa i gesty uznania i akceptacji,
- dbałość o dostarczanie na każdych zajęciach uczestnikom informacji, oceny ich wkładu pracy, zaangażowania, efektów działalności oraz wskazanie tych elementów, które wymagają modyfikacji, większego wysiłku i zaangażowania,
- określanie pożądanych osiągnięć po każdych zajęciach, by każdy uczestnik miał okazję osiągnąć sukces, uwierzyć we własne siły i możliwości.

FUNKCJONOWANIE EMOCJONALNE

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- identyfikowanie, diagnozowanie stanów emocjonalnych uczestników zajęć,
- właściwe reagowanie adekwatnie do reakcji uczestników,
- dbałość o właściwy dobór uczestników do zajęć (według różnych kryteriów ważnych z punktu widzenia prowadzącego i realizowanych treści)
- tworzenie przyjaznej, dobrej atmosfery w czasie zajęć,
- redukcja napięć poprzez wnikliwą obserwację czynników je wywołujących,
- minimalizowanie czynników powodujących napięcia, stres, lęk, strach,
- stosowanie tzw. rusztowania społecznego – posługiwanie się metodami wspierającymi porozumienie bez przemocy,
- docenianie wysiłków i osiągnięć – wprowadzenie systemu nagradzania za określone osiągnięcia – dbałość o pełnienie w czasie zajęć przez poszczególnych uczniów różnych

funkcji,

- ciągła kontrola aktywności w trakcie zajęć uczniów,
- kontrola rozumienia i prawidłowego realizowania treści programowych.

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- korzystanie z metod ułatwiających uczniom wczuwanie się w sytuację innych, współodczuwanie, rozumienie sytuacji (metody ekspresji, impresji, drama, symulacja, metody o charakterze aktywizującym),
- prezentowanie różnorodnych zachowań ludzkich na te same bodźce, w tych samych lub podobnych sytuacjach,
- rozróżnianie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
- dbałość o właściwą komunikację interpersonalną na zajęciach zarówno w gronie uczestników, jak i pomiędzy instruktorem i uczestnikami zajęć,
- stwarzanie atmosfery zapewniającej komfort, bezpieczeństwo, możliwość samorealizacji, rozwijania swoich umiejętności w tempie dostosowanym do indywidualnych możliwości uczestników zajęć, z uwzględnieniem przede wszystkim mocnych, ale też i słabych stron uczestników zajęć – osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- zapewnienie uczestnikom zajęć poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz dostarczenie różnorodnych doświadczeń społecznych,
- wspieranie w budowaniu realistycznego obrazu siebie oraz stwarzanie życzliwej i serdecznej atmosfery wychowawczej poprzez dostrzeganie i docenianie nawet drobnych, ale rzeczywistych sukcesów,
- zachęcanie do samodzielnego podejmowania decyzji i wykonywania zadań.

SPRAWNOŚĆ SENSORYCZNA: WRAŻLIWOŚĆ SŁUCHOWA

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- Usprawnianie funkcji słuchowych odbywa się przede wszystkim na materiale dźwiękowym.
- Materiał dźwiękowy powinien być wzbogacony o inne pomoce (np. zestawy obrazków, plansz itp.) ułatwiające kojarzenie dźwięków.

Im głębszy stopień upośledzenia, tym mniejsza efektywność oddziaływań terapeutyczno - kompensacyjnych.

MOTORYKA:

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- dbałość o koordynację statyczną,
- dokładność w prezentacji wykonania danego ruchu,
- stosowanie przerw relaksacyjnych,
- częste powtórzenia,
- dokładność w ćwiczeniu układu ruchów (kontrola terapeuty podczas pierwszych samodzielnych prób),
- podział skomplikowanych układów ruchów na etapy.

KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW PERCEPCYJNYCH:

Zalecenia do pracy terapeutycznej:

- dbałość o wyrazistość, czytelność przekazu zarówno słownego, jak i konkretnego (obrazek, fotografia, instrukcja słowna, pisemna)
- stwarzanie komfortowej atmosfery, sprzyjającej percepcji, rozumieniu, zapamiętywaniu,
- stosowanie różnych środków dydaktycznych,
- dbałość o właściwe miejsca pracy,
- dbałość o dobrze zorganizowaną i przeprowadzoną prezentację prowadzącego (dostępne stanowisko dla wszystkich uczestników zajęć, możliwość powtórek).

Działania terapeutyczne powinny być ukierunkowane na:

- stymulacje i korygowanie funkcji słabo rozwiniętych lub zaburzonych,
- rozwijanie nowych umiejętności,
- wykonywanie ćwiczeń i czynności wymagających zaangażowania zaburzonych funkcji

Prowadzona rehabilitacja, stosowane metody i formy terapii muszą uwzględniać indywidualne możliwości psychofizyczne osób upośledzonych. Zaburzone lub słabo

wykształcone funkcje umysłowe i sprawności osób z niepełnosprawnością intelektualną można wyćwiczyć na drodze intensywnego treningu.

Na poziomie motywacji i koncentracji uwagi, działania prowadzących zajęcia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną muszą skupiać się w szczególny sposób na warunkach uczenia się. Dotyczy to nie tylko dobrze oświetlonego miejsca, właściwego dostępu do źródeł informacji czy dopasowanego miejsca pracy, ale również stworzenia przyjaznej atmosfery sprzyjającej poczuciu bezpieczeństwa.

Ważne w rozwijaniu nowych umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną są też skuteczne wzmocnienia, takie jak: konkretne nagrody, dyplomy czy odznaki oraz organizowanie praktycznego kontekstu przekazywanej wiedzy.

Odmienne potrzeby oddziaływań dydaktycznych wymagają umiejętności odkodowania informacji zmysłowej, którą uczestnicy muszą osiąść, aby móc zrozumieć sens analizowanych sytuacji. Wiąże się to z procesem rozpoznania i zrozumienia szeregu symboli reprezentujących daną rzeczywistość, które pozwolą uczestnikom poruszać się w skomplikowanym świecie schematów, znaków i plansz.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często nie posiadają umiejętności samodzielnego porządkowania i powtarzania wiedzy. Dlatego tak ważne jest, aby te procesy odbywały się w różnych kontekstach, formach z wykorzystaniem różnych kanałów przekazu (np. audytywne, wizualne czy audiowizualne). Myśląc o trafnym oddziaływaniu należy również podkreślić znaczenie środków dydaktycznych oraz dobór właściwych form nauczania.

Zasady obowiązujące w nauczaniu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

- zasady dydaktyki ogólnej
 - szczegółowe zasady pracy dostosowane do rodzaju i zakresu niepełnosprawności
- Każdy człowiek ma swoje potencjalne możliwości.
- Każdy potrafi coś zrobić.

- Każdy człowiek ma prawo do uczenia się i rozwoju.
- Rozwój bazuje na umiejętnościach już opanowanych.
- Motywacja decyduje, na ile chcemy podwyższyć swoje kompetencje, nauczyć się czegoś nowego.
- Uczymy się przez doświadczenie i ćwiczenia.
- Uczymy się przez całe życie.

Zasady treningu umiejętności społecznych:

- Zasada partnerstwa – poszanowanie praw i indywidualności uczestnika zajęć, zdobycie zaufania, akceptacji i chęci współpracy.
- Zasada wielostronności oddziaływań – ćwiczymy różne umiejętności niezbędne do codziennego funkcjonowania i życia z innymi.
- Zasada powtarzalności oddziaływań
- Zasada zgodności psychospołecznych i biologicznych metod oddziaływania – łączenie treningu, rehabilitacji i leczenia farmakologicznego
- Zasada optymalnej stymulacji - niedobór bodźców i monotonia mogą powodować bierność i utratę zainteresowań. Nadmiar bodźców i stawianie zbyt trudnych zadań wpływa demobilizująco.
- Trening umiejętności społecznych zaczynamy po nawiązaniu tzw. kontaktu terapeutycznego.
- Trudności uczestnika formułujemy w kategoriach operacyjnych. Uwzględniamy mocne strony uczestników zajęć.
- Podajemy jasne instrukcje i wyjaśniamy każdy etap treningu.
- Podajemy i egzekwujemy od uczestników zajęć informacje zwrotne - dokonujemy ewaluacji oceny postępów treningu
- Tempo realizacji treningu dostosowujemy do aktualnych możliwości każdego uczestnika
- Stwarzamy warunki do aktywności
- Zachęcamy uczestników do podejmowania działań, inspirujemy ich aktywność własną

- Systematycznie obserwujemy zachowanie uczestników i udzielamy im niezbędnego wsparcia.

Specyfika działań dydaktycznych powinna uwzględniać także takie zabiegi edukacyjne jak:

- utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji;
- rozwijanie umiejętności odkodowania informacji zmysłowej lub znakowej;
- stosowanie komunikatów porządkujących wiedzę;
- realizowanie ciągłego procesu powtarzania;
- nadawanie edukacji kontekstu praktycznego.

Uczestnik zajęć, osoba z niepełnosprawnością intelektualną mająca specjalne potrzeby edukacyjne musi wiedzieć, jaki jest cel zajęć i jak zdobyta wiedza i umiejętności jest potrzebna do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Prowadzone zajęcia muszą również uwzględniać zasadę wszechstronnej znajomości uczestnika zajęć, która umożliwi odwoływanie się do jego doświadczeń i przeżyć.

Tworzenie praktycznego kontekstu sytuacyjnego związanego z życiem codziennym, sprzyja wytworzeniu się określonego spoiwa i spostrzeżeń łączących doświadczenia życiowe uczestnika i jego wiedzę na ich temat z treściami świeżo poznanymi na zajęciach, co umożliwia lepsze zapamiętanie, przechowanie oraz odtworzenie wiedzy.

2. KOMUNIKACJA, JĘZYK I MOWA

W otaczającym nas świecie mamy do czynienia z nieustannym obiegiem informacji, a osadzony w nim człowiek, posiada naturalną skłonność do jej poszukiwania i uzyskiwania. Dostęp do informacji otrzymujemy za pośrednictwem zmysłów i dzięki zachodzącym w mózgu operacjom myślowym. Rola człowieka nie ogranicza się jednak tylko do odbioru informacji i ich przetwarzania, my sami również jesteśmy **źródłem informacji** dla innych, a kiedy mamy wolę jej przekazania, stajemy się **nadawcami informacji**.

Proces wymiany informacji między nadawcą i odbiorcą, a także pomiędzy grupami i zbiorowościami ludzkimi nazywany jest **komunikowaniem się** bądź też **porozumiewaniem się**. Łaciński odpowiednik terminu komunikacja – *comunicare* oznacza „być w relacji, uczestniczyć, być w związku z.” (Słownik języka polskiego 1998) By omawiany akt komunikacyjny zaistniał, muszą być spełnione określone warunki.

Komunikowanie się jest procesem interpersonalnym, wymaga obecności co najmniej 2 osób, pozostających ze sobą w związku – w relacji. Niezbędne jest zatem nawiązanie kontaktu, np. poprzez zbliżenie się, wzbudzenie zainteresowania własną osobą, wejście w obszar uwagi drugiej osoby i stworzenie z nią wspólnego pola uwagi. W codziennych sytuacjach spotykamy szereg osób, z którymi wchodzimy w relacje, jedne z nich trwają dłużej, inne krócej, w jednych komunikujemy się częściej, w drugich rzadziej, a jeszcze w innych w ogóle. Są osoby, z którymi chcemy wchodzić w relacje, są też takie, których być może unikamy. Z osobami, które zaspokoją nasze potrzeby (rozumianymi w szerokim tego słowa znaczeniu), które są źródłem naszych inspiracji, z którymi łączą nas wspólne pasje i zainteresowania, cele, idee, działania, wchodzimy w relacje znacznie częściej. Pozostając w relacji, z człowiekiem w obecności, którego czujemy się m.in. bezpiecznie, akceptowani, wartościowi, potrzebni i sprawczy, istnieje większe prawdopodobieństwo zaistnienia aktu komunikacyjnego, niż w relacji z osobą, która nie daje nam poczucia bezpieczeństwa, jest nieprzewidywalna i traktuje nas w sposób dyrektywny.

Komunikacja ma swoje źródło w potrzebach człowieka. Potrzeby są motorem napędowym podejmowanych przez nadawcę i odbiorcę działań związanych z informacją. To potrzeby aktywizują człowieka do zachowywania się w określony sposób, w tym także do

komunikowania się. Kiedy chcemy coś mieć, być z kimś, czegoś uniknąć lub poznać określony element otaczającej rzeczywistości, stajemy się aktywni i jeżeli trzeba, odpowiednio modyfikujemy zachowanie, aż przyniesie ono skutek. Mówimy głośniej i wyraźniej, podchodzimy bliżej, analizujemy informacje pochodzące z kontekstu sytuacyjnego, prosimy o powtórzenie.

Wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą, wiąże się również z posiadaniem **motywacji** do takowej wymiany. Mimo realnie istniejących potrzeb, możemy pozostawać bierni, nie robiąc nic, by je zaspokoić. Dzieje się tak wówczas, gdy zachowania komunikacyjne nie spotykają się odbiorem, bo nikt nie zwraca na nie uwagi, bo są nietypowe i niezrozumiałe - generalnie, gdy nie przynoszą zamierzonych efektów. Brak sprawczych, skutecznych form ekspresji i recepcji informacji, skutkuje spadkiem motywacji angażowania się w tego typu zachowania. Jeżeli sygnalizujemy swoje potrzeby, a nikt w otoczeniu na to nie reaguje, bądź też reaguje, ale nie zaspokaja naszych potrzeb, to w którymś momencie stracimy motywację i zaprzestaniemy powielać nieskuteczne formy zachowań. Sytuacja powyższa manifestować się może wycofaniem z interakcji społecznej, biernością bądź też przyjęciem zewnątrz sterowanej postawy wobec innych. Tym bardziej nastąpi to szybko, gdy repertuar zachowań możliwych do zaprezentowania przez daną osobę będzie ograniczony np. z powodu niepełnosprawności.

Kolejnym ważnym elementem procesu komunikowania się jest obecność wiedzy nadawcy, dotyczącej tego jaką informację przekazać, jak ją zorganizować, a także w jaki sposób ją przekazać. Informacja, zanim zostanie przekazana, na początku ma charakter osobisty i znana jest tylko nadawcy. Jest wewnętrzną reprezentacją umysłową nadawcy, który dąży do tego, by identyczna reprezentacja umysłowa powstała w umyśle odbiorcy. By było to możliwe, konieczne jest jej uzewnętrznienie. W tym celu nadawca na poziomie umysłowym opracowuje program zewnętrznych środków, które uzewnętrzną wewnętrzny stan jego umysłu. Środkami, o których mowa są emitowane przez nadawcę zachowania.

Każde zachowanie możemy potraktować jako nośnik informacji o jego autorze, ponieważ podlega ono interpretacji i nadawane jest mu określone znaczenie. Dzieje się tak, niezależnie od tego czy prezentująca je osoba, chce przekazać informację, czy też nie. Widok dziecka, drepczącego w miejscu z przywartyimi do siebie kolanami, z wyciągniętą ręką

w kierunku kubka z wodą, czy też wpatrującego się w okno witryny sklepowej, to zachowania, których interpretacja dostarcza nam informacji o jego potrzebach .

Zachowań powyższych nie możemy traktować jednak jako komunikacji. Mogą być jedynie źródłem informacji, nie zawsze prawidłowo odczytanej. Osoba obserwująca może interpretować to zachowanie, ale wyciągnięte wnioski nie muszą być prawidłowe. Nie są zatem komunikacją, czyli wymianą informacji.

Zachowań powyższych, pomimo tego, iż są źródłem informacji, iż są jednocześnie zachowaniami intencjonalnymi, nie można traktować jako zachowań komunikacyjnych.

Zdolność człowieka do interpretacji zachowań nie czyni z nich zachowań komunikacyjnych.

Zachowanie komunikacyjne to zachowanie, które jest źródłem informacji, które jest skierowane do drugiej osoby, ale przede wszystkim, to zachowanie, którego autor ma **intencję - zamiar przekazania informacji**.

Informacja w procesie komunikowania się przekazywana jest w formie niejęzykowej i/lub językowej. W związku z powyższym możemy mówić o zachowaniach komunikacyjnych niejęzykowych i zachowaniach komunikacyjnych językowych. Zachowania niejęzykowe i zachowania językowe mogą ze sobą współwystępować.

Zachowanie niejęzykowe to zespół czynności wykonywanych przez człowieka, będących nośnikiem informacji, w których znaczenie przekazywane jest za pomocą ruchów, dźwięków, znaków nie spełniających cech języka naturalnego. Z uwagi na niejęzykowy charakter zachowań komunikacyjnych możemy mówić o **komunikacji niejęzykowej** bądź też o **komunikacji niewerbalnej**. Przykładem zachowań niejęzykowych o charakterze komunikacyjnym są, np. ruchy rąk (unoszenie, machanie, sięganie), przenoszenie kierunku spojrzenia, ruchy mimiczne twarzy, płacz, skinienie głową. Zalicza się tu także siłę, timbre i wysokość głosu, pauzy w toku mówienia, pantomimikę, postawę ciała, posługiwanie się przestrzenią.

Zachowanie językowe to pojęcie równoznaczne z pojęciem **mowy**, która jest zespołem, „czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego”. Zachowanie językowe realizowane może być tzw. **w mowie zewnętrznej**, nazywanej **komunikacją językową** lub **komunikacją werbalną**, której „wynikiem jest tekst zorganizowany w postać dźwiękową

(wtórnie w postać graficzną lub gestową), umożliwiającą porozumiewanie się w grupie społecznej.” Komunikacja językowa ma ścisły związek z językiem, odwołuje się do systemu znaków oraz reguł ich użycia. Realizowana jest w wyniku czynności mówienia, pisania i gestykulowania.

Zachowanie językowe to także akt użycia języka dokonujący się w tzw. **mowie wewnętrznej**, nazywany **cerebracją**, którego wynikiem jest pozbawiony warstwy fonicznej tekst pomyślany. Mowa wewnętrzna związana jest z poznawczymi procesami organizującymi w umyśle człowieka wiedzę i doświadczenie o rzeczywistości oraz z procesami quasi-komunikacyjnymi, organizującymi wiedzę i doświadczenie z zamiarem ich przekazania.

Wymienione powyżej zachowania komunikacyjne, jak każde zachowania pociągają za sobą określone konsekwencje. Nadawca, emitując zachowanie będące nośnikiem informacji, jest zainteresowany jego **sprawczością**. Oczekuje, by odbiorca potwierdził zachowaniem odbiór informacji. Ten może to zrobić pod warunkiem, że nadawca kierując komunikatem pozyskał jego uwagę, potrafił ją utrzymać, a emitując zachowania komunikacyjne użył form zrozumiałych dla odbiorcy. Odbiorca skieruje swoją uwagę na nadawcę, gdy będzie miał taką możliwość, potrzebę i motywację, a w jego umyśle powstanie obraz wewnętrznej reprezentacji umysłu nadawcy, gdy będzie rozumiał repertuar środków komunikacyjnych, którymi posłużył się nadawca. Proces porozumiewania wiąże się z nieustannym dokonywaniem przekładu informacji, ze strony nadawcy z jej wewnętrznej formy na zewnętrzną, a ze strony odbiorcy z jej formy zewnętrznej na wewnętrzną. Moment oczekiwania nadawcy na potwierdzenie odbioru informacji to moment, w którym powinna nastąpić zamiana ról między nadawcą i odbiorcą. Każdy uczestnik procesu komunikacyjnego w sposób **naprzemienny** pełni obydwie role. Dokonujący się przekaz informacji wymaga czasu i ma określoną ciągłość, a naprzemienność aktywności uczestniczących w nim partnerów komunikacyjnych sprawia, iż akt komunikacyjny staje się **dialogiem**. Dialog w ontogenezie rozwoju człowieka ma swój początek już w trakcie pierwszych interakcji niemowlęcia z matką. To dzięki matce dziecko odkrywa naprzemienny rytm interakcji komunikacyjnej, który ma miejsce w trakcie codziennie wykonywanych czynności, m.in. w trakcie karmienia, przewijania, zabiegów pielęgnacyjnych oraz w zabawie. Aktywność

dziecka w dialogu, początkowo jest aktywnością bez-słowną, ale w wyniku interakcji społecznych, w których modelowane są zachowania komunikacyjne, otrzymuje ono materiał językowy niezbędny do nauki języka, w rezultacie czego jego uczestnictwo w dialogu staje się dialogiem słownym.

Jako, iż proces komunikowania się przebiega nie tylko w wymiarze niejęzykowym, ale także w wymiarze językowym, nie sposób nie odnieść się do zagadnień związanych z językiem i mową. Zakres pojęć, komunikacja i język, pokrywa się ze sobą w sposób częściowy, a mianowicie wówczas, kiedy mowa jest o komunikacji językowej lub werbalnej. Natomiast nie pokrywają się ze sobą w obszarze komunikacji niejęzykowej czy też niewerbalnej oraz kiedy mówi się o języku w jego funkcji reprezentatywnej (przedstawieniowej), ponieważ język jest nie tylko narzędziem komunikowania się, ale także jest sposobem interpretowania rzeczywistości w umyśle. Natomiast jeżeli chodzi o relacje komunikacji i mowy, to pojęcia powyższe pokrywają się ze sobą, kiedy mówimy o komunikacji językowej, natomiast nie pokrywają się, kiedy mówimy o mowie wewnętrznej.

Język to system znaków i reguł ich użycia, natomiast **mowa** to konkretny akt użycia języka (Kurcz 2005: 16). Dla uzupełnienia definicji mowy, odwołam się także do definicji L. Kaczmarka (1982), który traktuje mowę jako dźwiękowy, oparty na języku, sposób porozumiewania się ludzi, w ramach którego wyodrębnić można czynność nadawania mowy, czynność odbioru mowy oraz wytwór mówienia i rozumienia nazywany **tekstem**. Nadawanie mowy (mówienie) jest zespołem czynności związanych z przekształcaniem spostrzeżeń, wyobrażeń, procesów myślowych w odpowiednie symbole (znaki)). Z kolei odbiór mowy to zespół czynności związanych z analizą i syntezą słyszanych dźwięków mowy oraz wiązania ich z określoną treścią.

Zestawiając ze sobą powyższe definicje języka i mowy, bez trudu dostrzegamy prymarną – priorytetową rolę języka, język bez mowy może istnieć, natomiast istnienie mowy bez języka jest nie możliwe. Centralne miejsce w definicji języka zajmuje pojęcie znaku. **Znak** to obiekt lub zjawisko postrzegane zmysłowo, które informuje o czymś i zastępuje określony element rzeczywistości. W literaturze przedmiotu obok pojęcia znaku

funkcjonuje również pojęcie symbolu. **Symbol** definiowany jest jako model rzeczy, działań lub zjawisk. W niniejszej pracy, terminy powyższe będą traktowane jako tożsame i odnosić się będą do znaków językowych spełniających kryteria języków naturalnych oraz języków sztucznych. Używane będą zamiennie. Znaki posiadają swoją formę i znaczenie, tzn. odnoszą się do czegoś z wyłączeniem samych siebie. Są symbolami elementów rzeczywistości, do których się odnoszą, a także w pełni niezależne od sytuacji, dlatego mogą odwoływać się do rzeczywistości, która nie podlega bezpośredniej percepcji. Charakteryzują się określonym czasem trwania i postrzegania. Mogą tworzyć **system**, tzn. układ znaków, w którym każdy element pozostaje w określonej relacji do innych elementów tego układu i pełni ściśle określoną funkcję. Zbiór znaków, tworzący system, używany do przekazywania informacji nazywany jest **kodem**. Język jest kodem, jednakże trzeba zauważyć, iż kod jest pojęciem nadrzędnym w stosunku do języka, ponieważ kodem są nie tylko znaki językowe, ale także inne systemy znaków funkcjonujące w świecie ludzi, zwierząt i maszyn. Warunkiem skutecznej komunikacji jest posługiwanie się przez partnerów komunikacyjnych, nadawcy i odbiorcy, tym samym systemem znaków.

Ze względu na funkcje znaki dzielą się na **symptomy**: czyli objawy, wskaźniki i przejawy jakiegoś zjawiska oraz na **sygnały**, które mogą być: językowe, migowo-językowe i niejęzykowe). Symptomy są znakami tylko dla odbiorcy, natomiast sygnały są zarówno dla odbiorcy jak i nadawcy. Symptomy mogą z czasem w wyniku procesu uczenia się przekształcać w sygnały. Przykładem przetransponowania znaku jednostronnego, odbieranego tylko przed odbiorcą, na znak dwustronny, który jest uświadamiany zarówno przez nadawcę i odbiorcę, są wczesne interakcje dziecka z matką, w których dziecko uświadamia sobie skutki swoich zachowań, a następnie w sposób celowy i zamierzony próbuje wywierać na nią wpływ.

Język to nie tylko system znaków, to także reguły ich użycia. Reguły powyższe to. min. reguły składniowe, gramatyczne i fleksyjne. Sprawne i skuteczne komunikowanie się w sposób językowy wymaga od partnerów interakcji posiadania określonej wiedzy

i umiejętności, które będą ją realizowały, a mianowicie: kompetencji językowej, kompetencji komunikacyjnej i kompetencji kulturowej.

Kompetencja językowa, jest terminem wprowadzonym przez Noama Chomsky`ego (1965/1982), który oznacza wiedzę umysłową związaną z posługiwaniem się systemem językowym. Ma ona swój komponent utajony, uwarunkowany biologicznie: uniwersalną gramatykę (UG) oraz komponent jawny, uwarunkowany społecznie: wiedzę metajęzykową. Uniwersalna gramatyka traktowana jest jako forma wiedzy utajonej, ponieważ o jej cechach możemy wnioskować dopiero na podstawie postrzeganych zachowań językowych (mowy, gestów języka migowego). Komponent utajony pozwala nam w sposób nieuświadomiony konstruować zdania zgodnie z regułami danego języka, natomiast komponent jawny pozwala nam rozumieć reguły, które stosujemy konstruując zdania, dzięki czemu wiemy, np. dlaczego jest ono poprawne gramatycznie.

Wyróżnia się trzy składniki kompetencji językowej (za: Kurcz, 2005):

- syntaktyczny – związany z regułami składni,
- semantyczny – związany ze znaczeniem zdania,
- fonologiczny – związany z dźwiękową formą zdania, którego jednostką fonologiczną jest fonem – najmniejszy możliwy do zidentyfikowania dźwięk mowy.

Kompetencja komunikacyjna, jest terminem wprowadzonym przez Della Hymes (1972), który oznacza umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji społecznej i do relacji z innymi uczestnikami interakcji komunikacyjnej. „Jednostką tej kompetencji jest **wypowiedź** i leżący u jej podstaw **akt mowy**, czyli **intencja mówiącego**. Pojęciem łączącym w sobie przynajmniej dwie wypowiedzi (np. Pytanie - Odpowiedź) jest **dyskurs**,” . Posiada swój komponent utajony, uwarunkowany biologicznie: teorię umysłu (TU), oraz komponent jawny, uwarunkowany społecznie: **wiedzę meta pragmatyczną**. Kompetencja komunikacyjna uwarunkowana jest znajomością znaków wykorzystywanymi w procesie komunikowania się, a także rozumieniem sytuacji, w której dany znak można zastosować

Kompetencja kulturowa, jest terminem propagowanym m.in. przez Ernesta Cassirera, Teodozję Rittel, Stanisława Grabię, który oznacza wiedzę na temat zjawisk rzeczywistości powstającą z udziałem języka. Jej rozwój umożliwia poznawanie nowych terminów, symboli i znaków współczesnej cywilizacji i kultury, a także reguł i sposobów ich zastosowania. Każda z wymienionych kompetencji realizuje odmienne funkcję, które się wzajemnie uzupełniają, umożliwiając efektywny rozwój zdolności i umiejętności posługiwania się językiem, każda z nich też może ulegać różnym zaburzeniom. „Zaburzenie kompetencji językowej nosi nazwę specyficznego zaburzenia rozwoju językowego, a zaburzenie kompetencji komunikacyjnej – autyzmu”.

3. OPIS ROZWIĄZANIA I JEGO FUNKcjONALNOŚCI

Prototyp aplikacji został zaprojektowany i wykonany zgodnie z zapotrzebowaniem grupy docelowej, jaką są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Aplikacja na potrzeby realizacji innowacji została umieszczona w chmurze i jest dostępna dla każdego urządzenia typu android (w okresie realizacji innowacji). Po pobraniu aplikacji na urządzenie android, wystarczy zarejestrować się a następnie zalogować na swoje konto.

W aplikacji występują dwa typy użytkowników: opiekun, który ma dostęp do kont wszystkich uczestników oraz użytkownicy właściwi. Dzięki takiemu podziałowi, opiekun ma możliwość monitorowania postępów uczestników i sprawdzania, które z tematów nie są opanowane w sposób zadowalający i wymagają powtórzenia.

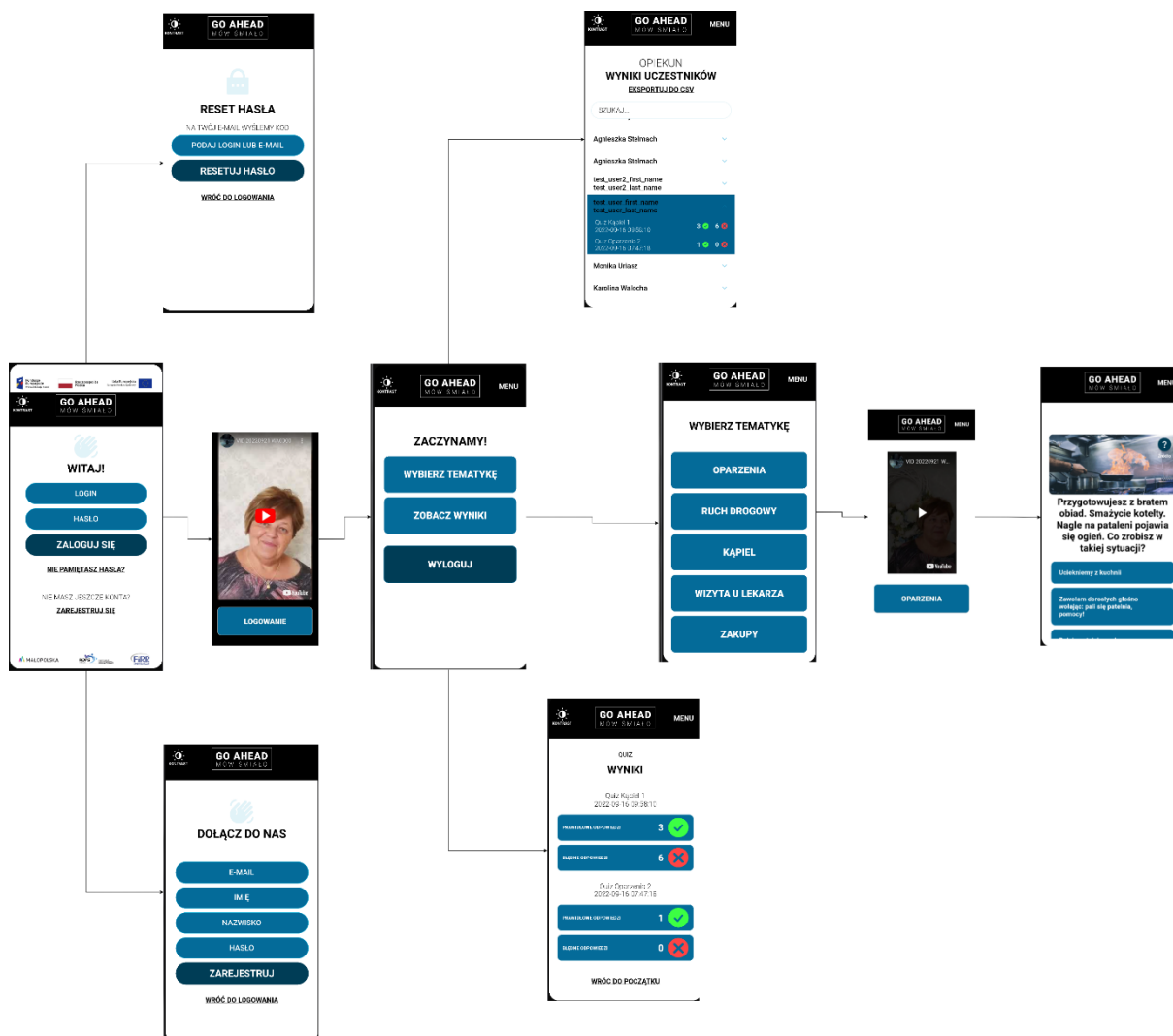
Dzięki monitorowaniu postępów nabywania wiedzy i kompetencji komunikacyjnych uczestników możliwa jest ewaluacja tematów oraz ich zawartości. Drugim rodzajem użytkownika są testerzy aplikacji/pozostali odbiorcy, którzy mają możliwość wykonywania zawartych w aplikacji zadań/quizów.

Po pobraniu aplikacji z linku uruchamiamy ją na telefonie. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się. Jest ono proste i nie wymaga potwierdzenia rejestracji. Po rejestracji można się zalogować do aplikacji za pomocą adresu email oraz hasła - w ten sposób

rozpoczynamy. Osoba korzystająca z aplikacji ma możliwość dowolnego wyboru tematów, ich kolejność nie jest odgórnie narzucona.

Aplikacja zawiera 5 historyjek/quizów a każda z nich składa się z minimum 5 „kroków”. Użytkownik otrzymuje graficzne przedstawienie „historyjki” (czyli określonej sytuacji społecznej) a jego zadaniem jest wybór komunikatu zwrotnego, właściwego do określonej sytuacji. Efektem jego akcji jest określona reakcja uczestnika „rozmowy” przedstawiona w formie emotikonów. Po przejściu wszystkich kroków w danej „historyjce” użytkownik ma dostęp do informacji o sukcesie swoich działań. Każdy quiz/historyjka został poprzedzony filmikiem instruktażowym. Dodatkowo wszystkie wyniki są zapisywane na koncie użytkownika z datą i godziną wypełniania testu oraz ilością prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi.

Schemat aplikacji mobilnej



Funkcje aplikacji mobilnej:

1. Logowanie



Przyciski login oraz hasło służą do wprowadzenia danych dostępowych. Przycisk „nie pamiętasz hasła?” służy do przejścia do widoku resetu hasła. Natomiast „zarejestruj się” służy do przejścia do widoku rejestracji.

2. Reset hasła



W celu resetu hasła należy w przycisku „podaj login lub e-mail” podać email lub login użytkownika, który ma mieć zresetowane hasło. Przycisk „wyślij kod” wysyła żądanie na serwer.

3. Reset hasła potwierdzenie



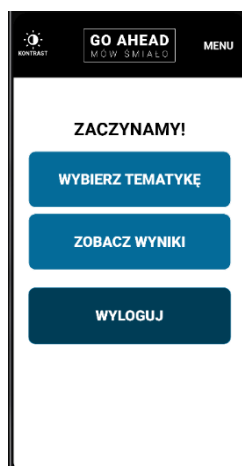
W przycisku „podaj kod” użytkownik wprowadza kod, który dostał na e-mail, który potwierdza, że e-mail należy do niego. W przycisku „nowe hasło” ustawia nowe hasło. Przycisk „zapisz hasło” wysyła żądanie na serwer.

4. Rejestracja



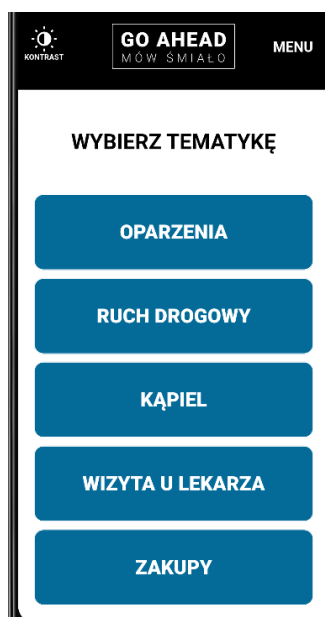
Widok odpowiada za rejestrację nowego użytkownika. Użytkownik uzupełnia dane i poprzez przycisku „ZAREJESTRUJ” wysyła je na serwer.

5. Wybór opcji



Przycisk „wybierz tematykę” odpowiedzialny jest za przejście do wyboru tematów, natomiast „Zobacz wyniki” odpowiada za przejście do ekranu wyników użytkownika.

6. Wybór tematyki



W tym ekranie użytkownikowi wyświetlane są tematyki edukacyjne.

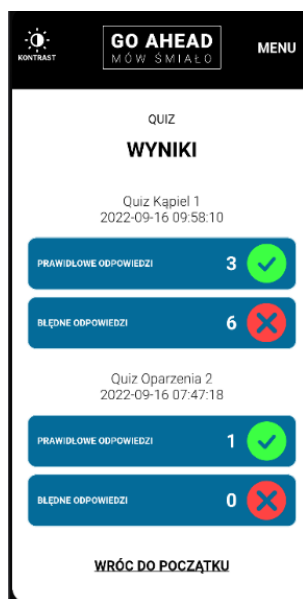
7. Lekcja



Na ekranie użytkownikowi wyświetlana jest lekcja. Po kliknięciu w zdjęcie, wyświetlany jest jego opis.

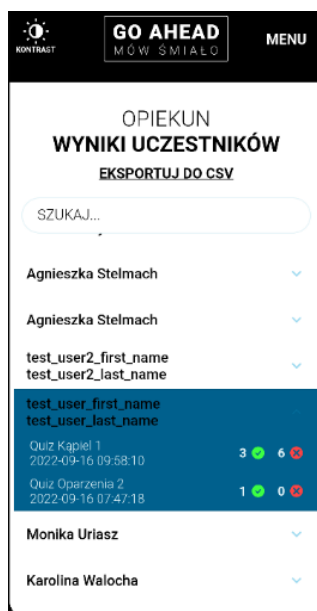
Niektóre zdjęcia są w formie pytań na które użytkownik może udzielić odpowiedzi. Po kliknięciu na odpowiedź, użytkownikowi wyświetlana jest informacja o poprawności i uzasadnieniu odpowiedzi.

8. Wyniki uczestnika



Ekran pokazuje użytkownikowi informację o wynikach jego quizu. Wyniki sortowane są malejąco na podstawie daty ukończenia quizu.

9. Wyniki z perspektywy opiekuna



Ekran ukazuje opiekunowi wyniki uczestników quizu w formie zagnieżdżonej listy. W polu „Szukaj” może filtrować po imieniu oraz nazwisku danego użytkownika aplikacji.

Ekran pokazuje ilość poprawnych i nieprawidłowych odpowiedzi udzielonych przez użytkownika.

4. Program szkolenia dla kadry

Przed rozpoczęciem używania aplikacji opiekunowie grup powinni odbyć szkolenie z zakresu użytkowania aplikacji oraz wszystkich jej funkcji. W ten sposób zyskują odpowiednią wiedzę i kompetencje aby prowadzić zajęcia z grupami testującymi aplikację. Przewidywany czas szkolenia: 2h zegarowe. Poniżej przedstawiono ramowy plan szkolenia:

1. Zapoznanie użytkowników z aplikacją
 - a) Ogólne przedstawienie aplikacji
 - b) Przedstawienie układu aplikacji
2. Przejście przez flow aplikacji
 - a) Przejście przez flow z punktu widzenia zwykłego użytkownika
 - b) Przejście przez flow z punktu widzenia opiekuna
3. Zapoznanie użytkowników z systemem logowania
 - a) zapoznanie użytkowników z rejestracją
 - b) zapoznanie użytkowników z logowaniem
 - c) zapoznanie użytkowników z resetem hasła
 - d) zapoznanie użytkowników z kontem administratora
 - e) zapoznanie użytkowników ze sposobem tworzenia konta opiekuna
4. Zapoznanie użytkowników z systemem „Tematów” w aplikacji
 - a) Zapoznanie z systemem lekcji
 - b) Zapoznanie z systemem quizów
5. Zapoznanie użytkowników z systemem wyników
 - a) Zapoznanie użytkowników z podglądem wyników pojedynczego użytkownika
 - b) Zapoznanie użytkowników ze zbiorczym podglądem wyników wszystkich użytkowników
 - c) Zapoznanie użytkowników z systemem eksportu danych z aplikacji.

Instrukcja użytkowania dla kadry:

Aplikacja „Go ahead – MÓW ŚMIAŁO” jest narzędziem do nauki prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych i wzbogacania umiejętności komunikacyjnych użytkowników.

Zasady użytkowania urządzenia:

1. Pobierz urządzenie na telefon z oprogramowaniem android. Link do aplikacji to:

<https://drive.google.com/file/d/1jOle7K9YCO-HbGBHP042I1CPVpMUSbRY/view?usp=drivesdk>

2. Po pobraniu aplikacji należy założyć własne konto poprzez kliknięcie w pole „ZAREJESTRUJ SIĘ” i podanie wymaganych danych.

3. Kliknij „ZAREJESTRUJ” – zapamiętaj podane przez siebie dane: LOGIN I HASŁO.

4. Następnie zaloguj się na swoje konto. Wpisz wybrany przez siebie LOGIN i HASŁO i kliknij „ZALOGUJ SIĘ”.

5. Po zalogowaniu ukażą się pola z napisami: WYBIERZ TEMATYKĘ, ZOBACZ WYNIKI I WYLOGUJ.

6. Aplikacja ma formę Quizów o tematyce: OPARZENIA, RUCH DROGOWY, KĄPIEL, WIZYTA U LEKARZA i ZAKUPY. Wybierz i kliknij w pole z interesującym cię tematem.

7. Po dotknięciu pola z wybranym tematem pokażą się komunikaty lub zdjęcia związane z różnymi sytuacjami dotyczącymi wybranej tematyki i kolejne pola z możliwymi odpowiedziami/reakcjami.

8. Po dokonaniu wyboru ukaże się emotikonka przedstawiająca reakcję na odpowiedź, po której możesz poznać czy odpowiedź była właściwa i opis, który będzie tłumaczył dlaczego dana odpowiedź jest poprawna lub dlaczego jest błędna.

9. Jeśli chcesz sprawdzić ile udzieliłeś dobrych, a ile złych odpowiedzi kliknij w pole „ZOBACZ WYNIKI”.

10. Jeżeli będziesz chciał sprawdzić swoją wiedzę z kolejnego tematu, kliknij „NASTĘPNY TEMAT”, a następnie „WYBIERZ TEMATYKĘ”.

11. Jeżeli chciałbyś zakończyć korzystanie z aplikacji kliknij w pole WYLOGUJ.

Życzę zadowolenia z korzystania z aplikacji.

5. Narzędzia monitorujące postępy uczestników

Innowacja „Go ahead” zakłada dwa rodzaje monitorowania postępów uczestników:

- Pierwszy jest wbudowany w aplikację – rejestr odpowiedzi użytkowników.
Gromadzone wyniki wypełnionych quizów po każdej lekcji/temacie, który będzie omawiany z uczestnikami pozwolą na obserwację przyrostu wiedzy. Sposób liczbowy monitorowania postępów ułatwia późniejsze przeliczenie procentowe w skali całej aplikacji, czyli 5 lekcji z różnych tematów rozwijających kompetencję komunikacyjną osób z niepełnosprawnością.
- Drugi rodzaj monitorowania odbywa się w czasie i po zajęciach - ma on formę ankiety wypełnianej przez osobę prowadzącą (wzór ankiety poniżej).

Wzór ankiety dla prowadzących zajęcia:

Tabela 1:

	Data spotkania:	Tak	Nie	Czasami	Uwagi dodatkowe
1.	Czy aplikacja jest łatwa w obsłudze dla uczestnika?				
2.	Czy aplikacja jej możliwość wykorzystania wpływają na motywację uczestnika ?				

	Data spotkania:	Tak	Nie	Czasami	Uwagi dodatkowe
3.	Czy uczestnik potrzebuje pomocy przy obsłudze aplikacji ?				
4.	Czy samodzielnie wykonuje zadania?				
5.	Sposób pracy: samodzielny, czasami oczekuje pomocy, najczęściej oczekuje pomocy, bierny *Podkreśl właściwe				
6.	Aktywność/ zaangażowanie na zajęciach: aktywnie uczestniczy, wskazuje bierny Stosunek wobec zleconych mu zadań, nie chce brać udziału *Podkreśl właściwe				
7.	Inne				

Uzyskane dane liczbowe przedstawione w formie procentów z obydwu narzędzi monitorujących postępy uczestników pozwolą na sprawdzenie efektywności aplikacji w rozwoju kompetencji komunikacyjnych osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Trzeci rodzaj monitoringu postępu użytkowników odbywał się za pomocą arkusza ankietowego wypełnianego przez użytkowników aplikacji (na pierwszych i ostatnich zajęciach ten sam, ze wsparciem prowadzących), który pozwolił zweryfikować postępy w nabywaniu

kompetencji społecznych. Zostały one zawarte w scenariuszach zajęć w formie quizów sprawdzających wiedzę uczestników.

6. Scenariusze zajęć

Test rozwiązania z wykorzystaniem aplikacji poprzedzały spotkania grupowe dotyczące poszczególnych tematów poruszanych w aplikacji. Prowadzone były przez terapeutów, którzy kontynuowali w dalszej kolejności indywidualne spotkania z wykorzystaniem aplikacji. Miały one charakter wprowadzający do tematu i pozwalały zintensyfikować oddziaływania edukacyjne.

Scenariusz zajęć nr 1: Temat: Dbam o zdrowie - HIGIENA OSOBISTA

Uczestnicy zajęć: 8 osób (2 grupy po 4 osoby) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczestników WTZ

Cel ogólny:

- uświadomienie potrzeby przestrzegania higieny osobistej,
- kształtowanie nawyku mycia rąk i korzystania z codziennej kąpieli.
- przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności samoobsługowych w zakresie prawidłowych nawyków higienicznych.
- wdrażanie uczestników do utrzymywania ładu i porządku w pomieszczeniach sanitarnych.

Cele szczegółowe:

- Poznanie zasad higieny osobistej,
- poznanie i stosowanie odpowiedniej kolejności przy myciu rąk,
- kształtowanie umiejętności mycia rąk,
- kształtowanie umiejętności społecznych (stosowanie form grzecznościowych, porządkowanie po sobie łazienki, pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi innych osób),
- rozwijanie myślenia i bogacenie słownika za pomocą zabaw dydaktycznych,
- rozwijanie umiejętności odpowiedniego korzystania z przyborów toaletowych oraz przedmiotów służących do higieny osobistej,

- wdrażanie do wykonywania kolejnych czynności związanych z myciem całego ciała.
- doskonalenie umiejętności prawidłowego używania mydła, ręcznika, grzebienia, gąbki, szczoteczki.
- rozumienie konieczności zmiany bielizny osobistej i odzieży.
- wdrażanie do zachowania zasady niekorzystania z cudzych przedmiotów osobistego użytku.

Cele operacyjne:

Uczestnik:

- rozpoznaje i nazywa przybory toaletowe,
- samodzielnie wykonuje zabiegi higieniczne, potrafi poprawnie umyć się i wytrzeć,
- wykazuje zainteresowanie zdobywaniem wiedzy dotyczącej higieny,
- potrafi umyć ręce i całe ciało zachowując kolejne etapy,
- odtwarza ruchem demonstrowane czynności mycia rąk, mycia całego ciała,
- poznaje przybory toaletowe, służące do utrzymania higieny ciała,
- rozpoznaje węchem produkty służące do higieny osobistej,
- rozumie znaczenie higieny osobistej dla funkcjonowania organizmu,
- uczestnik podejmuje indywidualne decyzje dotyczące preferowanych środków higieny osobistej adekwatnie do jego potrzeb (odpowiedni dezodorant, mydło, szampon).

Metody:

- Czynne: ćwiczenia praktyczne, kierowanie aktywnością uczestnika, wykonywanie zadań.
- Słowne: rozmowy, opowiadanie, objaśnienia i instrukcje.
- Percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykład instruktora.
- zabawy ruchowe,
- zajęcia plastyczne.

Formy pracy:

- indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne i pomoce do zajęć:

- Plakat z mottem lekcji: MOTTO: „*Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz*” (Jan Kochanowski).

- różne przybory do higieny osobistej i ilustracje związane z tym tematem,
- plakaty tematyczne np. *Etapy mycia rąk*,
- komputer z dostępem do Internetu do wykorzystania materiałów dydaktycznych, np.: film
- pokaz prawidłowego mycia rąk -<https://www.youtube.com/watch?v=m5uEjEV0eDY>
- środki dydaktyczne zamieszczone na portalu Scholaris: Przybory do kąpieli produkty higieny osobistej,
- kolorowanka – łazienka,
- teksty wierszy związanych z tematem zajęć,
- zagadki tematyczne.

Tematyka zajęć:

- Zasady mycia rąk
- Zasady mycia całego ciała

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna

1. Powitanie - Przywitanie się uczestników różnymi częściami ciała (np. ręką, kolanem, kciukiem, łokciem). W trakcie przywitania uczestnicy poruszają się swobodnie po sali i wykonują kolejne polecenia instruktora: podchodzą do każdej osoby z grupy i witają się wymienioną przez instruktora częścią ciała.

2. Podanie tematu i celu zajęć.

- Rozmowa kierowana nt. Znaczenie higieny (dla zdrowia, funkcjonowania społecznego); Nauczyciel prowadzi dalej dyskusję wzbudzając wśród uczestników zainteresowanie tematem oraz chęć wypowiedzi. Przykładowe pytania: Do czego służy woda? co powinno się znajdować w łazience? Kiedy należy myć ręce? Jakie przybory służą do mycia rąk? Jakie przybory potrzebne są do umycia zębów? Dlaczego należy się myć?.

Zabawa ruchowa: Uczestnicy wykonują polecenia instruktora:

- Wstaną i zamienią się miejscami osoby, które dzisiaj myły zęby;

- Wstaną i zamienią się miejscami osoby, które dzisiaj czesały włosy,
- Wstaną i zamienią się miejscami osoby, które myły dzisiaj ręce.

II. Realizacja tematu

1. Omówienie etapów mycia rąk:

- Odkręć wodę
- Zamocz ręce i nadgarstki
- Nałóż mydło - najlepiej mydło w płynie
- Myj ręce zaczynając od:
 - paznokci
 - wewnętrznej strony dłoni
 - palców po kolei
 - przestrzeni między palcami
 - spodu dłoni
 - wierzchu dłoni
 - kciuków
 - nadgarstków
- Oplucz ręce
- Wytrzyj ręce do sucha, najlepiej w ręcznik papierowy.

2. Utrwalenie wiadomości: Oglądanie filmu edukacyjnego – *Zasady mycia rąk*

3. Omówienie etapów kąpieli całego ciała

Kolejność czynności:

1. Przygotowujemy ręczniki, środki higieny osobistej do kąpieli, czystą bieliznę, środki do sprzątania łazienki
2. Zdjąć ubranie.
3. Spłukać ciało ciepłą wodą.
4. Namydlić ciało, szczególnie pachy, pachwiny, stopy.
5. Spłukać ciało ciepłą wodą.
6. Wytrzeć ciało ręcznikiem.

7. Założyć czystą bieliznę.
8. Odłożyć na miejsce przybory toaletowe.
9. Rozczesujemy włosy
10. Umyć wannę i umywalkę.
11. Umyć i wytrzeć podłogę.

4. Omówienie zasad dbałości o czystość otoczenia, zwłaszcza pomieszczeń sanitarnych (łazienka, toaleta)

5. Utrwalenie wiadomości:

Przeprowadzenie (rywalizacja 2 grup uczestników) quizu na temat „Higiena osobista”

Podział grupy na 2 drużyny za pomocą losowania kolorowych patyczków. Kolejno odpowiadają na pytania.

Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt., za błędną -1 pkt. a pytanie przechodzi na grupę drugą, która może podać odpowiedź. Prowadzący zapisuje punkty na tablicy.

- Polecenie: Dokończ poniższe zdania na temat higieny osobistej.

Powstanie w ten sposób dekalog zasad, które każdy człowiek powinien stosować.

1. Szczotkuj zęby przez minuty, przynajmniej 2 razy dziennie.
2. Zmieniaj szczoteczkę do zębów na nową, co
3. Myj całe swoje ciało pod prysznicem lub w wannie.....
4. Po wizycie w toalecie
5. Zmieniaj bieliznę osobistą.
6. Myj ręce przed każdym

Prawidłowe odpowiedzi:

- Pyt.1 - 3 minuty,
- Pyt. 2 - 1 miesiąc,
- Pyt. 3 - raz dziennie,
- Pyt. 4 - wymyj ręce,
- Pyt. 5 - codziennie,
- Pyt. 6 - posiłkiem.

III. Zajęcia aktywizujące:

1) Ćwiczenie: Co służy do mycia?:

- oglądanie przyborów do mycia, grupowanie elementów na te, które służą do kąpieli, do mycia rąk, zębów, pielęgnacji włosów itp.

2) Zabawa:

- rozpoznawanie za pomocą dotyku zakrytych tkaniną przedmiotów służących do utrzymania higieny ciała (np. szczotka do pielęgnacji paznokci, szczotka do zębów, mydelniczka, ręcznik, gąbka, pumeks; myjka, szczotka do mycia pleców)
- rozpoznawanie węchem produktów służących do higieny osobistej, np.: pasta do zębów, mydło w płynie, krem do rąk, dezodorant;

3) Zabawa ruchowa z elementem naśladownictwa (Pantomima):

Myjemy zęby, twarz, ręce, włosy, nogi, kąpiemy się; przedstawienie czynności związanych z dbaniem o higienę. Na początku instruktor wydaje polecenia, a następnie zastępuje go chętny uczestnik.

IV. Podsumowanie zajęć - utrwalenie wiedzy

1) Zagadki

W celu utrwalenia poznanych już informacji nauczyciel zadaje zagadki, na które dzieci będą starać się odpowiedzieć. Wybrany uczestnik odnajduje odpowiedź także wśród obrazków.

2) Kolorowanie obrazków związanych z higieną.

3) Podsumowanie instruktora – podkreślanie znaczenia częstego mycia rąk, higieny całego ciała.

Podziękowanie za czynny udział w zajęciach.

Materiały do zajęć:

Zagadki:

Rozpuszczam się w wodzie,
ubywa mnie co dzień.

Kto o czystość dba,
ten mnie dobrze zna. (MYDŁO)

Kot ma długie, ostre,
często nimi drapie.

Wystrzegaj się bardzo,
żebyś nie miał takich. (PAZNOKCIE)

Chociaż mam zęby, to nic nie jadam

Tylko splątane włosy układam (GRZEBIEŃ)

Kim jestem? Pytam siebie!

Patrząc na mnie – widzisz siebie (LUSTERKO)

Rymowanki:

- KTO SIĘ CHĘTNIE ORAZ CZĘSTO MYJE MAŁO CIERPI, DŁUGO ŻYJE!
- KIEDY ZNAJDĘ SIĘ W ŁAZIENCIE NAJPIERW SIUSIU - POTEM RĘCE.
- WODA I MYDŁO TO NAJLEPSZE PACHNIDŁO!
- W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH.

Wiersz I. R. Salach „Czystość to zdrowie”

Kiedy rano wstaję, do łazienki idę,
kran odkręcam z ciepłą wodą i dokładnie myję ...
zęby, twarz i szyję.

Gdy już się ubiorę, to przeczeszę włosy,
by nie sterczał krzywo w górę
ani jeden kosmyk.

Ręce zawsze czyste mam,
O paznokcie krótkie dbam.
Czyste włosy mam i szyję
no bo się dokładnie myję.

Żeby zdrowym zawsze być,
Trzeba się dokładnie myć.
I pamięta każdy zuch:
W zdrowym ciele zdrowy duch.

Rozmowa na temat wiersza:

- Co robimy rano, gdy wstajemy z łóżka?
- Co robimy, gdy się już ubierzemy?
- Co trzeba robić, żeby zawsze być zdrowym?
- Co znaczy powiedzenie – w zdrowym ciele zdrowy duch?

Zagadka: Co to są choroby brudnych rąk?

„Choroba brudnych rąk” – choroby wywołujące zatrucia pokarmowe; drobnoustroje chorobotwórcze są przenoszone poprzez brudne ręce, nie myte owoce i warzywa spożywane na surowo, brudne naczynia (np. żółtaczką, czerwonością).

Ćwiczenie sprawdzające: Poniżej wypisano różne przedmioty, które znajdują się w łazience.

Czerwonym kolorem podkreśl te przybory higieniczne, które każdy powinien mieć i których nie wolno nikomu pożyczać:

mydło - grzebień - krem do rąk - szczoteczka do zębów - suszarka do włosów - dezodorant - pasta do zębów – ręcznik - gąbka do kąpieli - proszek do prania - szampon do włosów

QUIZ – ANKIETA EDUKACYJNA: Czy dbasz o zdrowie i znasz podstawowe zasady higieny?

Odpowiedz na poniższe pytania?

1. Czy myjesz zęby po każdym posiłku?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

2. Czy najchętniej na drugie śniadanie jadasz owoce, ciemne pieczywo i pijesz sok?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

3. Czy śpisz w ciągu nocy minimum 9 godzin?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

4. Czy wietrzysz pokój w trakcie nauki i przed snem?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

5. Czy chodzisz na kontrolne badania do dentysty przynajmniej raz na pół roku?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

6. Czy myjesz ręce przed każdym posiłkiem, a także po wizycie w toalecie?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

7. Czy myjesz się rano?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

8. Czy zmieniasz codziennie bieliznę osobistą?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

9. Czy myjesz owoce i warzywa przed jedzeniem?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

10. Czy po zabawie z psem lub kotem myjesz ręce?

TAK – 5 CZASAMI – 2 NIE – 0

WYNIKI:

36 – 50 pkt. – Gratuluję! Jesteś osobą, która nie tylko zna podstawowe zasady higieny, ale stosuje je w życiu codziennym. Prawdopodobnie, nie będziesz miał kłopotów ze swoim zdrowiem.

20 – 35 pkt. – Osiągnięty przez Ciebie wynik jest zadawalający. Musisz popracować nad sobą. Wygląda, bowiem na to, że znasz podstawowe zasady higieny, lecz brakuje Ci wytrwałości w ich stosowaniu.

0 – 19 pkt. – Wynik ten świadczy niezbyt dobrze o Tobie. Albo nie znasz, zasad higieny, albo jesteś zbyt leniwy, żeby je stosować. Musisz, czym prędzej to zmienić, inaczej będziesz miał kłopoty ze swoim zdrowiem.

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

W pytaniach prawidłowa jest 1 odpowiedź lub należy podać swoją odpowiedź.

Pytania:

1. Nigdy nie pożyczaj

- a) szamponu do włosów (b) szczoteczki do zębów c) suszarki do włosów

2. Szczotkuj zęby przez 2 minuty, przynajmniej:

- a) 1 raz dziennie (b) 3 razy dziennie c) po każdym posiłku.

3. Zmieniaj szczoteczkę do zębów na nową, co

- a) co miesiąc b) co 2 miesiące (c) co 3 miesiące

4. Jak często powinieneś myć całe ciało pod prysznicem lub wannie?

- (a) raz dziennie b) 2 razy dziennie c) po każdym zabrudzeniu

5. Jak często powinieneś zmieniać bieliznę osobistą?

- (a) codziennie b) co 2 dzień c) raz na tydzień

6. Jak często kontrolujemy stan uzębienia u stomatologa?

- a) co miesiąc (b) co pół roku c) co rok

7. Każdy z domowników powinien mieć:

- a) własną pastę do zębów (b) własny ręcznik c) własny szampon do włosów

8. Myję ręce (podaj 3 sytuacje):

9. Obcinamy paznokcie

- a) codziennie b) co 2 dni (c) kiedy są zbyt długie

10. Odzież powinna być

- a) czysta i modna b) modna i wygodna (c) czysta

Scenariusz zajęć nr 2: Temat: BEZPIECZEŃSTWO NA ULICY

Uczestnicy: 8 osób (2 grupy po 4 osoby) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczestników WTZ.

Czas zajęć: Materiał przygotowany na zajęcia może być realizowany na 2 (90 min) lub 3 godzinach lekcyjnych – zależnie od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć lub całego zespołu.

Cel główny:

Organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczestników WTZ na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i poruszania się w lokalnym środowisku.

Uświadomienie zagrożeń istniejących w ruchu drogowym.

Wyposażenie uczestników w takie umiejętności i wiadomości, które spowodują, że staną się oni świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, dbającymi o bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe:

- poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się w środowisku i przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych
- poznanie zasad przechodzenia przez przejście z sygnalizacją świetlną
- nauka odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię bez sygnalizacji świetlnej.
- utrwalenie wiedzy i umiejętności uczestników na temat zasad poruszania się pojazdów i pieszych po drodze:
- Ukazanie sytuacji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie na drodze.

Cele operacyjne:

Uczestnik zajęć:

- potrafi określić miejsca bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię (sygnalizacja świetlna, pasy, znak informacyjny – przejście dla pieszych)
- rozpoznaje kolory sygnalizacji świetlnej i określa ich przeznaczenie
- wskazuje znaki drogowe oznaczające przejście dla pieszych,
- potrafi właściwie reagować na znaki i sygnały
- potrafi umiejętnie zademonstrować poprawne przechodzenie przez jezdnię
- zna zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach,
- zna 5 zasad przechodzenia przez jezdnię,
- dba o bezpieczeństwo swoje i innych. potrafi prawidłowo ocenić i uniknąć ryzyka związanego z ruchem drogowym, na podstawie znajomości znaków.
- potrafi korzystać z informacji zawartych na znakach drogowych

Pomoce i środki dydaktyczne:

- plansze, ilustracje przedstawiające przejścia dla pieszych (z sygnalizacją, bez sygnalizacji),
- plansza ze znakiem drogowym: przejście dla pieszych
- plansza/zdjęcia z omawianymi elementami drogi (droga, pobocze, chodnik, sygnalizacja świetlna, przejście dla pieszych),
- plansze przedstawiające scenki bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
- wiersze tematyczne,
- karty pracy,
- kredki/farby, klej,
- sprzęt multimedialny
- linki do filmów dydaktycznych o ruchu drogowym

Metody pracy:

- podające:
 - pogadanka
 - objaśnianie
- praktyczna

- pokaz
- ćwiczenia praktyczne: wypełnianie kart pracy, ćwiczenia w przechodzeniu przez zebra
- burza mózgów,
- ćwiczenia ruchowe,

Formy:

- praca z grupą
- praca indywidualna z uczestnikiem zajęć

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE:

I. Znaki i sygnały drogowe

- Pojęcie znaku i sygnału
- Rodzaje znaków: ostrzeżenia, zakazy, nakazy i informacje
- Typy znaków: pionowe, poziome, sygnały świetlne, znaki osób uprawnionych, sygnały dźwiękowe
- Sposób reagowania na poszczególne znaki
- Hierarchia ważności znaków
- Konsekwencje braku respektowania znaków drogowych

II. Zasady poruszania się po drodze

- Podstawowe zasady ruchu pieszych w terenie zabudowanym i poza nim
- Zasady poruszania się pieszych po zjeździe
- Zasada szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania
- Zasady poruszania się kolumny pieszych

- Miejsca szczególnie niebezpieczne dla pieszych (tory, skrzyżowania, zakręty)
- Zagrożenia, jakie występują na drodze (niesprzyjające warunki drogowe)
- Zasady zachowania w momencie ograniczenia widoczności drogi (trudne warunki atmosferyczne, zakręty, zaparkowane samochody).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Wstęp – nawiązanie do tematu:

- Instruktor pokazuje makiety znaków drogowych, sygnalizatora oraz pasów dla pieszych - zadaniem uczestników zajęć jest odgadnąć, o czym będą dzisiejsze zajęcia.
- Instruktor pokazuje zdjęcie przedstawiające zebrawą (zwierzę) oraz pasy na przejściu dla pieszych (zebra); pyta uczestników, co przedstawiają te dwa zdjęcia. - Rozmowa z uczniami ma doprowadzić do stwierdzenia, że to samo słowo ma inne znaczenie.
- Instruktor pokazuje przejście dla pieszych i przedstawia temat zajęć: *Bezpieczeństwo na drodze*

II. Realizacja tematu:

Rozmowa kierowana: Nauczyciel zadaje pytanie: *Dlaczego w niektórych miejscach na ulicy są zaznaczone przejścia dla pieszych?* Pomysły uznane za najtrafniejsze zostają zapisane na tablicy.

- Instruktor wyjaśnia podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię. Czyta wiersz Wandy Chotomskiej „*Gdy zamierzam przejść przez ulicę*”

Na chodniku przystać bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna, więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.

Uczestnicy zajęć wykonują opisane w wierszu czynności.

- Wycieczka na przejścia dla pieszych w pobliżu Warsztatów Terapii Zajęciowej
 - Uczniowie wraz z nauczycielem wychodzą na zewnątrz w celu obserwacji ruchu drogowego.
- W czasie wyjścia uczestnicy zajęć mają za zadanie: obserwowanie sposobów przechodzenia przez ulicę, sprawdzenie, czy wybrane w czasie zajęć rozwiązania stosowane są w rzeczywistości, jakie znaki drogowe oznaczają przejścia.

W miarę możliwości uczestnicy powinni zobaczyć przejścia z sygnalizacją oraz bez. Nauczyciel zwraca uwagę na znaki oznaczające przejście dla pieszych.

- Po powrocie rozmowa o zaobserwowanych sposobach przechodzenia przez ulicę.
- Wspólne zastanowienie się, które zachowania pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia przez ulicę.

Są to:

- zatrzymanie się przed przejściem,
- sprawdzenie, czy żaden pojazd się nie zbliża,
- szybki krok w czasie przechodzenia przez jezdnię

Zasady przechodzenia przez jezdnię (zilustrowane znakami drogowymi):

- 1. Zatrzymaj się** – przed wejściem na pasy należy zawsze się zatrzymać, nawet kiedy przechodzimy przez przejście z sygnalizacją świetlną. - **znak drogowy STOP**
- 2. Popatrz** – przed wejściem na przejście dla pieszych należy rozejrzeć się: w lewo, w prawo oraz ponownie w lewo
- 3. Posłuchaj** – uczestnicząc w ruchu drogowym należy zwracać uwagę również na dźwięki, które mogą sygnalizować zbliżające się niebezpieczeństwo, jadący samochód lub motor.

4. Pomyśl – przed przekroczeniem jezdni bez sygnalizacji świetlnej zawsze należy przeanalizować sytuację, czy mamy odpowiednią ilość czasu na przejście nim nadjeżdżający pojazd.

- **OMÓWIENIE ZASAD PRZECHODZENIA PRZEZ DROGĘ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLĄ**

1. **ŚWIATŁO CZERWONE**  - **STÓJ**
2. **ŚWIATŁO ŻÓŁTE**  - **UWAŻAJ!** Przygotuj się na zmianę światła!
3. **ŚWIATŁO ZIELONE**  - **PRZEJDŹ** na drugą stronę drogi

- **PORUSZANIE SIĘ POBOCZEM** – prowadzący przekazuje uczestnikom informacje:
 - Pieszy jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 - Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim.
 - Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
 - Pieszy po zmierzchu jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.
 - Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
- **PORUSZANIE SIĘ NA ROLKACH** – prowadzący przekazuje uczestnikom informacje:
 - **Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym osobę poruszającą się na rolkach obowiązują przepisy dotyczące ruchu pieszych, a nie na przykład rowerzystów.**
 - Jadąc na rolkach nie zapomnij o odpowiednich ochroniaczach, kasku i odblaskach.

- **Rozmowa z uczestnikami** na temat ich doświadczeń w poruszaniu się poboczem w środowisku, powtarzanie obowiązujących zasad

III. Ćwiczenia praktyczne:

- Rozmowa na temat konsekwencji kontaktu pieszego z pojazdem mechanicznym

Ćwiczenie: .

Uczestnicy wybierają duże twarde przedmioty np. meble i stukają w nie dłońią.

Następnie powtarzają czynność, uderzając lekko w swój brzuch:

Rozmowa na temat doznań i odczuć: „Co czujecie stukając w stół/ szafkę i brzuch. Czujecie różnicę? Ciało ludzkie jest miękkie, a stół/ szafka twarde – to tak jak twardy jest pojazd.

Przy zderzeniu z pojazdem człowiek zawsze ulega wypadkowi i potrzebuje pomocy.

- Zabawa muzyczno- ruchowa utrwalająca znajomość kolorów i prawidłowych zachowań na kolor czerwony i zielony. Uczestnicy chodzą po sali, instruktor pokazuje szablony świateł czerwonego i zielonego. Zadaniem uczestników zajęć jest zatrzymać się na widok światła czerwonego, chodzić po sali, gdy instruktor pokazuje szablon światła z kolorem zielonym.
- Zabawa ruchowa utrwalająca znajomość kierunków: prawy, lewy, na wprost
Uczestnicy zajęć stają za krzesłami, instruktor prosi o: spojrzenie w lewo, prawo; naprzemienne podnoszenie do góry prawej i lewej ręki; równoczesne podniesienie do góry obu rąk; naprzemienne unoszenie prawego i lewego kolana; pochylenia tułowia w lewą stronę, pochylenia tułowia w prawą stronę; wykonanie kilku kroków przed siebie – każde ćwiczenie należy wykonać kilkakrotnie.
- **Ćwiczenie:** Każdy z uczestników zajęć przechodzi przez wyznaczoną „ulicę” – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
 - zatrzymanie się przed wejściem na ulicę
 - schowanie telefonu,
 - spojrzenie w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo
 - słuchanie, czy nie zbliża się żaden pojazd
 - przejście żwawym krokiem na drugą stronę.

Pogratulowanie każdemu z uczestników, który prawidłowo przeszedł przez „ulicę”.

- Wykonanie pracy plastycznej: malowanie farbami sygnalizatora świetlnego.

IV. Podsumowanie - Przypomnienie podstawowych informacji z zajęć nt. bezpieczeństwa na drodze.

Pytania do uczestników zajęć:

- kogo najczęściej można spotkać na chodniku, a kto porusza się po drogach?
- czy można przebiegać przez ulicę?
- czy można wchodzić na ulicę na czerwonym świetle?
- czy można wchodzić na ulicę na zielonym świetle?
- czy można przechodzić przez ulicę, gdy nie ma pasów dla pieszych?
- czy dzieci mogą same chodzić po ulicy?
- czy na ulicy można grać w piłkę?
- czy jadąc na rowerze można czepiać się innych pojazdów?
- czy bezpiecznie jest zjeżdżać z góry na sankach prosto na ulicę?
- Co się może wydarzyć kiedy pieszy spotka się z samochodem?
- Jakie mogą być konsekwencje takiego spotkania?
- Jak należy się zachować, aby być bezpiecznym na drodze? – **powtórzenie zasad przechodzenia przez jezdnię:**

1. Zatrzymaj się przed wejściem na pasy i przez przejście z sygnalizacją świetlną.

2. Popatrz – przed wejściem na przejście dla pieszych należy rozejrzeć się: w lewo, prawo oraz ponownie w lewo

3. Posłuchaj – uczestnicząc w ruchu drogowym należy zwracać uwagę również na dźwięki, które mogą sygnalizować zbliżające się niebezpieczeństwo, jadący samochód lub motor

4. Pomyśl – przed przekroczeniem jezdni bez sygnalizacji świetlnej zawsze należy przeanalizować sytuację, czy mamy odpowiednią ilość czasu na przejście nim nadjeżdżający pojazd.

5. Nie korzystamy z telefonu podczas przechodzenia przez ulicę (nie należy rozmawiać przez telefon, grać na nim, oglądać ani robić zdjęcia) - Dlaczego takie postępowanie może być niebezpieczne? (ponieważ przeszkadza to w skupieniu i właściwej analizie sytuacji).



Instruktor dziękuje uczestnikom za udział w zajęciach.

ANKIETA SPRAWDZAJĄCA:

1. ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLĄ

DOPASUJ ODPOWIEDNIE KOMUNIKATY DO KOLORU ŚWIATŁA

Oznaczenie	Znak	Komunikat
Światło żółte oznacza:		PRZEJDŹ na drugą stronę drogi
Światło czerwone oznacza:		UWAŻAJ! Przygotuj się na zmianę światła!
Światło zielone oznacza:		STÓJ

2. CO OZNACZAJĄ ZNAKI DROGOWE

Znak drogowy		Prawidłowa odpowiedź
		Przeście dla pieszych
		Znak STOP - oznacza: nakaz zatrzymania się przed skrzyżowaniem lub drogą z pierwszeństwem przejazdu,
		"Sygnały świetlne" - znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Znak drogowy		Prawidłowa odpowiedź
		Miejsce uczęszczane przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. (szkoły podstawowe, gimnazja, placówki prowadzące zajęcia z dziećmi, tereny zabaw itp.
		Przejazd kolejowy

3. WYMIENŲ ZASADY PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ:

Prawidłowa odpowiedź:

- 1) Zatrzymaj się
- 2) Spójrz w lewo
- 3) Spójrz w prawo
- 4) Ponownie spójrz w lewo
- 5) Jeżeli nic nie jedzie, idź szybkim krokiem, nie korzystaj z telefonu

4. ODPOWIEDZ NA PONIŻSZE PYTANIA: TAK LUB NIE

Nr.	Pytanie	TAK	NIE
1.	Czy można przebiegać przez ulicę?		
2.	Czy można wchodzić na ulicę na czerwonym świetle?		
3.	Czy można wchodzić na ulicę na zielonym świetle?		

Nr.	Pytanie	TAK	NIE
4.	Czy można wchodzić na ulicę na żółtym świetle?		
5.	Czy można przechodzić przez ulicę, gdy nie ma pasów dla pieszych?		
6.	Czy na ulicy można grać w piłkę?		
7.	Czy jadąc na rowerze można czepiać się innych pojazdów?		
8.	Czy bezpiecznie jest zjeżdżać z góry na sankach prosto na ulicę?		

Scenariusz zajęć nr 3 Temat zajęć: PIERWSZA POMOC PRZY OPARZENIU

Cele kształcenia:

Cele ogólne:

- zapoznanie z najczęściej spotykanymi przyczynami oparzeń
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy po oparzeniach,
- podniesienie świadomości o zagrożeniach oparzeniem w codziennym życiu
- poznanie sposobów zapobiegania oparzeniom
- wdrażanie do zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe:

- wyrobienie nawyku ostrożności w sytuacjach zagrażających oparzeniom
- nauka udzielania pomocy w przypadku oparzeń termicznych
- zapoznanie uczestników z zasadami postępowania w przypadku oparzeń I stopnia

- zapoznanie uczestników z zasadami postępowania w przypadku oparzeń II stopnia
- poznanie domowych sposobów radzenia sobie w sytuacji niewielkich oparzeń,
- nauka zgłaszania zdarzenia do służb ratowniczych – wzywania pogotowia ratunkowego

Cele operacyjne:

Uczestnik zajęć:

- zna potencjalne źródła poparzeń (emitery wysokiej temperatury, środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym, zagrożenia oparzeniem słonecznym),
- zna objawy oparzeń I i II stopnia,
- zna zasady udzielania pomocy z objawami oparzenia I i II stopnia,
- zna numery telefonów alarmowych.

Uczestnik zajęć potrafi:

- prawidłowo zachować się w sytuacji oparzenia,
- udzielić pomocy osobie z oparzeniem termicznym,
- udzielić pomocy osobie z oparzeniem słonecznym i udarem słonecznym,
- dobrać materiały opatrunkowe do opatrzenia rany po oparzeniu,
- założyć jałowy opatrunek, jeżeli sytuacja tego wymaga,
- wykorzystać środki przynoszące ulgę oparzonemu, znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy,
- wezwać pomoc do poszkodowanego,
- powiadomić dorosłych o niebezpiecznym zdarzeniu,
- prawidłowo pielęgnować poszkodowanego do czasu przybycia profesjonalnej pomocy.

Metody:

Metody podające: opis, opowiadanie, pogadanka;

Metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne, symulacje;

Metody aktywizujące: burza mózgów, analiza przypadków

Formy pracy:

Dyskusja kierowana, pokaz ilustracji, filmów edukacyjnych, praca indywidualna, praca w zespole, ćwiczenia w parach, komunikaty motywujące uczestników do aktywności, komunikaty korygujące;

Środki dydaktyczne:

- ilustracje przedstawiające źródła zagrożeń oparzeniem ,
- tablice informacyjne,
- symbole reprezentujące niebezpieczne substancje ,
- ilustracje/fotografie różnych stopni oparzeń,
- filmy edukacyjne;
- prezentacja multimedialna
- plansze dydaktyczne ilustrujące zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń,

Pomoce dydaktyczne:

Rzutnik multimedialny, telefon, komputer, apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem: gaza, bandaż, przyłepiec, nożyczki, plaster z opatrunkiem, rękawiczki lateksowe;

Uczestnicy zajęć: 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 grupy po 4 osoby);
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej

Czas realizacji: 90 min.

Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie do tematu

1. Wyjaśnienie, czym jest oparzenie: „*to uszkodzenie tkanki skóry na skutek działania wysokiej temperatury lub substancji żrących*”.
 2. Burza mózgów- uczestnicy zajęć podają sytuacje, w których dochodzi do oparzeń ciała;
 3. Wypisanie sytuacji zagrażających oparzeniem na tablicy .
- dotknięcie rozgrzanego przedmiotu;

- Miejsca przygotowywania posiłków (kuchenka: groźba przechylenia się garnka z gorącym płynem, gorący tłuszcz z patelni, możliwość zapalenia się tłuszczu na patelni);
- możliwość oparzenia się parą przy otwieraniu gorącego piekarnika;
- ściągnięcie z kuchenki garnka/ patelni z gorącą potrawą – zwracać uwagę na odpowiednie ustawienie garnka, zwłaszcza z długim uchwytem, wystającym poza powierzchnię kuchenki;
- oblanie się gorącym płynem np.: gorące napoje, posiłki;
- parzące rośliny, m.in.: Barszcz Sosnowskiego, pokrzywa, wilczomlecz, jaskółcze ziele, arcydzięgiel, niebezpieczne zwłaszcza w słoneczne dni, mogą parzyć także na odległość;
- grill;
- długotrwałe opalanie się i przebywanie na słońcu;
- ukąszenia owadów (np. czerwone mrówki);
- żrące substancje chemiczne;
- prąd elektryczny;

4. Dyskusja – uczestnicy opowiadają o sytuacjach, w których doznali oparzeń, ich przeżyciach, zachowaniach (co robili, kto im pomógł, co robił);

5. Terapeuta uzupełnia wypowiedzi uczestników, posługuje się foliogramami, zdjęciami z sytuacji zagrażających oparzeniem;

6. Rozmowa, jak wygląda skóra po oparzeniu, terapeuta pokazuje ilustracje – informuje o różnych stopniach oparzeń;

Stopnie oparzeń i ich objawy:

I stopień – zaczerwienienie skóry,

II stopień – bąble na skórze,

III stopień – zwęglenie skóry.

II. Zajęcia praktyczne – trening radzenia sobie w przypadku oparzenia

1. Prowadzący demonstruje środki opatrunkowe, podaje ich nazwy ; uczestnicy powtarzają: gaziki, plastry, opaska uciskowa, bandaż, plastry z opatrunkiem;
2. Określanie nazw i przeznaczenia środków opatrunkowych – (rywalizacja 4 osobowych zespołów)
3. Pokaz terapeuty: postępowanie po oparzeniu (chłodzenie miejsca oparzenia,
4. Ćwiczenia w opatrywaniu oparzonych miejsc (symulacje) – zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy po oparzeniu.

Pierwsza pomoc:

I stopień - polewanie miejsce oparzone zimną wodą przez około 20 minut,

- przykrywamy oparzone miejsce gazą sterylną,
- położyć oparzonego, unieść mu nogi, zapewnić spokój,
- wezwać osobę dorosłą.

II stopień (i III)

- nie zdejmować przylepionej odzieży (jedynie pierścionki i paski),
- nie przekłuwać pęcherzy,
- opatrzyć ranę po zaschnięciu,
- udać się do lekarza.

5. Wzywanie pogotowia ratunkowego do zdarzenia: oparzenie

a) zapoznanie uczestników z numerami służb ratunkowych : 112 i 999

b) demonstracja terapeuty: wzywanie pogotowia ratunkowego

b) ćwiczenia praktyczne uczestników zajęć – każdy z uczestników ćwiczy umiejętność wzywania pogotowia wg zasady:

Meldunek o wypadku:

1. miejsce wypadku,
2. rodzaj wypadku,
3. liczba poszkodowanych i ich stan,

4. informacja o udzielonej pomocy,
5. dane personalne zgłaszającego.

III. **Podsumowanie zajęć** – powtórzenie podstawowych wiadomości na temat udzielania pierwszej pomocy po oparzeniach.

1. Pierwsza pomoc po oparzeniu – rozróżnianie, kiedy pomoc może być udzielona w miejscu oparzenia, a kiedy należy udać się do lekarza;
2. Rozmowa na temat sposobów zapobiegania oparzeniom – bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrażających oparzeniem – Pogadanka: „*Lepiej zapobiegać niż leczyć oparzenia*”

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

1) Właściwą reakcją na oparzenie jest:

- a) założenie bandaża elastycznego
- b) posmarowanie oparzonego miejsca maścią
- c) polewanie miejsca oparzonego zimną wodą przez około 20 minut

2) Czy można przekłuwać bąble po oparzeniu? (zakreśl właściwą odpowiedź)

TAK - NIE

3) Objawy oparzenia to (podkreśl właściwe:

siniaki - zaczerwienienie skóry – wysypka (krostki) - bąble na skórze – zwęglenie skóry.

4) Jakie numery mają służby ratownicze? Dopasuj (strzałkami) odpowiednie numery do pojazdów ratowniczych.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Rodzaj pojazdu	Numer telefonu
	997
	999
	112
Europejski numer alarmowy to:	998

Prawidłowe odpowiedzi:



112 Alarmowy
998 Straż
997 Policja
999 Pogotowie

5) Dopasuj numery odpowiednich służb ratowniczych do sytuacji na ilustracjach

Kogo wezwiesz? Pod jaki numer zadzwonisz? Zakreśl właściwy numer.



997 - 999 - 112 - 998



997 - 999 - 112 - 998



997 - 999 - 112 - 998



997 - 999 - 112 - 998

Scenariusz zajęć nr 4 :Temat: WIZYTA U LEKARZA.

Uczestnicy: 8 osób (2 grupy po 4 osoby) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczestników WTZ.

Czas zajęć: Materiał przygotowany na zajęcia może być realizowany na 2 (90 min) lub 3 godzinach lekcyjnych – zależnie od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć lub całego zespołu.

Cele kształcenia:

Cel ogólny:

- organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczestników WTZ na temat wizyty u lekarza
- uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie i regularności wykonywania badań
- wyposażenie uczestników w takie umiejętności i wiadomości, które spowodują, że staną się oni świadomymi pacjentami, osobami dbającymi o zdrowie własne i innych

- przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności społecznych.

Cele szczegółowe:

- wyrobienie nawyku dbania o stan swojego zdrowia
- dostrzeganie związku pomiędzy działaniami profilaktycznymi, chorobą a leczeniem, poddawanie się leczeniu – uczestnicy wiedzą że przyjmowanie leków, regularne badania oraz wizyty u lekarza są konieczne
- nauka zgłaszania zdarzeń do służby ratowniczej – wzywania pogotowia ratunkowego
- poznanie domowych sposobów radzenia sobie w sytuacji przeziębienia, niewielkich infekcji
- ukazanie sytuacji które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia (unikanie dużych skupisk ludzi chorych, unikanie przeciągów)
- kształtowanie umiejętności odpowiedniego doboru ubioru do panujących warunków pogodowych
- kształtowanie umiejętności społecznych (stosowanie form grzecznościowych (m. in. w trakcie wizyty u lekarza i w aptece), w razie potrzeby pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi innych osób)
- rozwijanie myślenia i bogacenie słownika za pomocą zabaw dydaktycznych,
- wdrażanie do wykonywania czynności, zaleceń lekarza oraz regularności przyjmowania leków, wykonywania badań które w razie potrzeby zalecił lekarz

Cele operacyjne:

Uczestnik:

- umie prawidłowo dbać o swoje zdrowie

- dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem
- potrafi wezwać pomoc w postaci pogotowia ratunkowego
- zna domowe sposoby radzenia sobie w sytuacji prostych infekcji, przeziębień
- rozpoznaje sytuacje które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia
- odpowiednio dobiera odzież do warunków pogodowych
- rozumie znaczenie regularnych badań i wizyt u lekarza dla prawidłowego funkcjonowania organizmu
- potrafi powiadomić dorosłych o niebezpiecznym zdarzeniu
- prawidłowo stosuje formy grzecznościowe
- potrafi umiejętnie opisać i ocenić stan swojego zdrowia
- wymienia sytuacje, w których należy udać się do lekarza
- zna przebieg wizyty u lekarza i nazwy podstawowych specjalizacji lekarskich (np. dentysta, okulista itp.)

Metody:

- czynne: ćwiczenia praktyczne, kierowanie aktywnością uczestnika, wykonywanie zadań
- słowne: rozmowy, opowiadanie, instrukcje i objaśnienia
- percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykłady instruktora
- zajęcia z kartami pracy.

Formy pracy:

- indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne i pomoce do zajęć:

- ilustracje przedstawiające sytuacje które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia,
- prezentacja multimedialna,
- plansze dydaktyczne dotyczące umiejętności prawidłowego zachowania się podczas wizyty lekarskiej
- filmy edukacyjne
- komputer z dostępem do Internetu

Przebieg zajęć:

I. Wprowadzenie do tematu:

1. Wyjaśnienie czym jest zdrowie „*stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności*”.
2. Burza mózgów – uczestnicy zajęć podają sytuację, w których dochodzi do utraty zdrowia lub sytuacji, które mogą przyczynić się do powstania choroby.
3. Wypisanie na tablicy sytuacji które mogą spowodować utratę zdrowia.
 - przebywanie w dużych skupiskach chorych osób
 - nieumiejętne dostosowanie ubioru do warunków pogodowych
 - znajdowanie się w miejscach dużych przeciągów
 - przebywanie w miejscach w których występują substancje szkodliwe, alergenów itp.
 - nieostrożne, nieumiejętne korzystanie ze sprzętów domowych
 - niewłaściwe żywienie, niezdrowy tryb życia
 - lekceważenie pierwszych objawów choroby.
4. Dyskusja – uczestnicy opowiadają o sytuacjach, w których byli chorzy opisują swój stan w jakim byli oraz próbują znaleźć przyczynę swojej choroby. Dyskutują na temat ich przeżyć oraz zachowaniach, które im towarzyszyły. Starają się opisać jakie kroki poczynili aby polepszyć swój stan zdrowia (udanie się do lekarza, zastosowanie odpowiednich leków).

5. Terapeuta uzupełnia wypowiedzi uczestników, posługuje się zdjęciami, planszami związanymi ze stanami zdrowia i choroby.

6. Rozmowa, jak wygląda przebieg wizyty lekarskiej. Terapeuta pokazuje ilustracje informuje o prawidłowych, akceptowalnych społecznie zachowaniach związanych z wizytą w przychodni, szpitalu itp.

II. Zajęcia praktyczne – trening radzenia sobie w sytuacji wizyty u lekarza.

1. Prowadzący demonstruje na kartach, obrazkach sytuacje choroby (np. katar, ból głowy, ból gardła, ból pleców) .
2. Uczestnicy losują jedną kartę obrazującą stan chorobowy i określają jak może czuć się osoba, która posiada taką dolegliwość. Dostrzegają, że niezależnie od faktu co boli daną osobę powinna udać się po pomoc.
3. Uczestnicy starają się dopasować wyznaczone objawy i choroby do odpowiednich specjalizacji lekarskich.
4. Pokaz terapeuty z zastosowaniem prezentacji multimedialnej oraz filmu pt. „Wizyta u lekarza”.
5. Ćwiczenia praktyczne uczestników – wizyta u lekarza (z wykorzystaniem wcześniej wylosowanej dolegliwości).

Krótką odpowiedź:

1. Powitanie z lekarzem
2. Ocena i opis swojego stanu zdrowia
3. Wysłuchanie i odpowiedź na pytania zadawane przez lekarza
4. Przyjęcie recept, skierowań i ewentualne dopytanie o szczegóły związane z leczeniem
5. Podziękowanie za pomoc lekarzowi
6. Pożegnanie

III. Podsumowanie zajęć

1. Powtórzenie podstawowych wiadomości na temat wizyty u lekarza, określenia i oceny swojego stanu zdrowia.
2. Wykonywanie kart pracy.

3. Podziękowanie za wspólne zajęcia.

Karta pracy „Wizyta u lekarza”

Zadanie 1. Z podanych poniżej atrybutów wybierz te, które przedstawiają atrybuty lekarza.

[link do kart pracy Bezpieczny Przedszkolak](#)



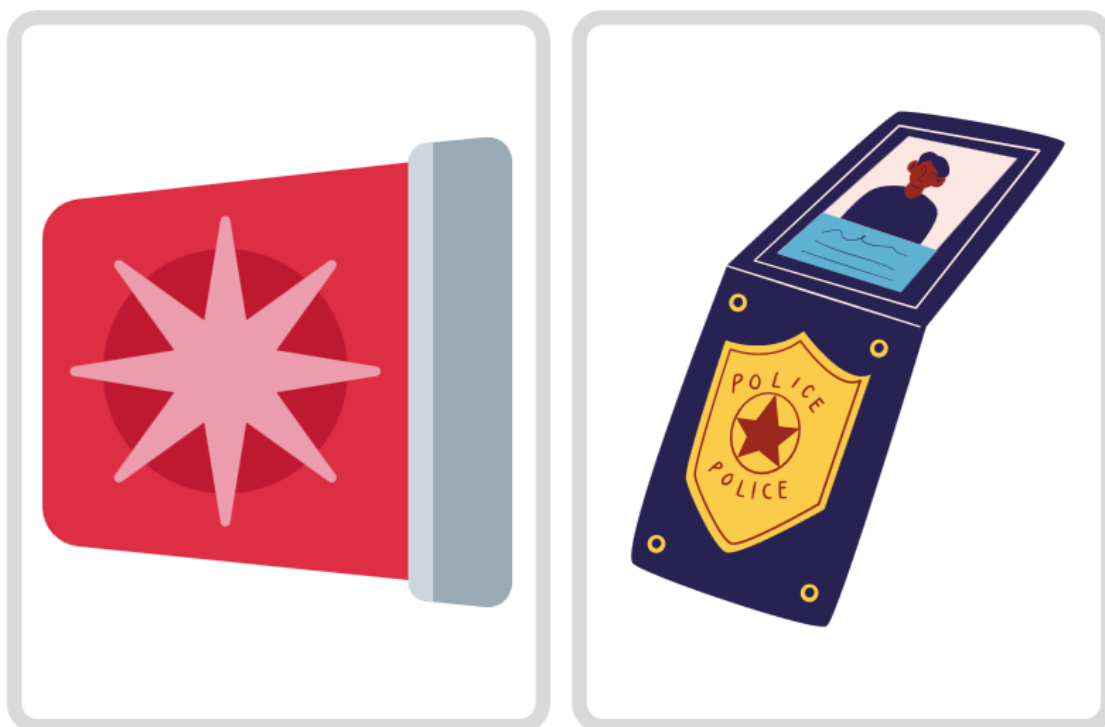


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pani Ania na tropie pomysłów!



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pracujmy na tropie pomysłów!



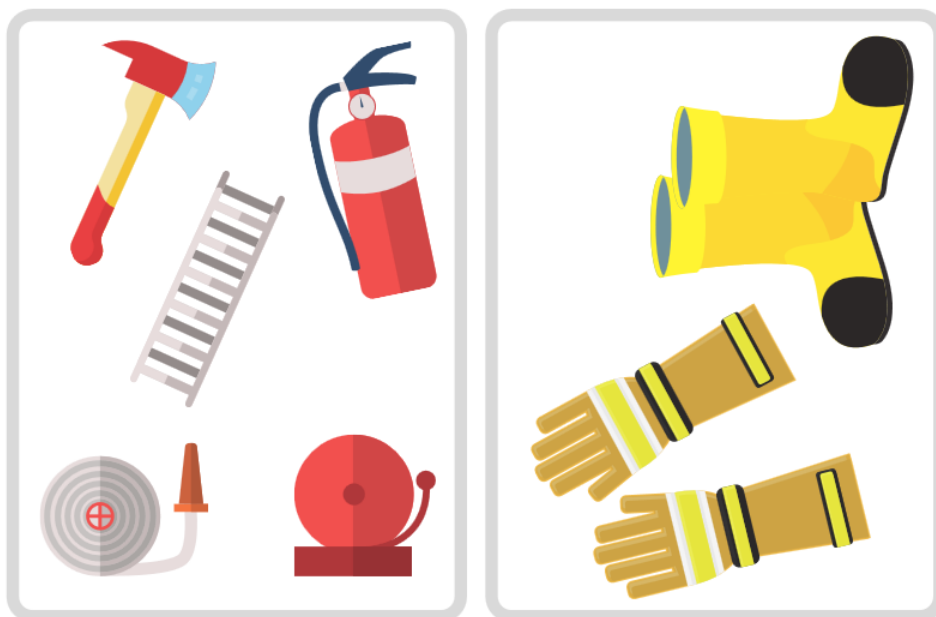


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pani Ania na tropie pomysłów!



Pani Ania na tropie pomysłów!





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Pani Ania na tropie pomysłów!



999

Pani Ania na tropie pomysłów!

Opis: Szkic na Tępisie pomysłów



Opis: Szkic na Tępisie pomysłów



Zadanie 2. Kiedy boli Cię gardło, kaszlesz, masz katar i bolą Cię kości udajesz się do:

- a) Stolarza
- b) Kosmetyczki
- c) Lekarza
- d) Fryzjera

Zadanie 3. Czy można samemu bez konsultacji z lekarzem stosować leki: (zakreśl właściwą odpowiedź)

TAK – NIE

Zadanie 4. Spośród podanych poniżej nazw wybierz te które dotyczą specjalizacji lekarzy:

OKULISTA

NAUCZYCIEL

LARYNGOLOG

POLICJANT

PEDIATRA

AKTOR

STOMATOLOG

ELEKTRYK

CHIRURG

GEODETA

PSYCHIATRA

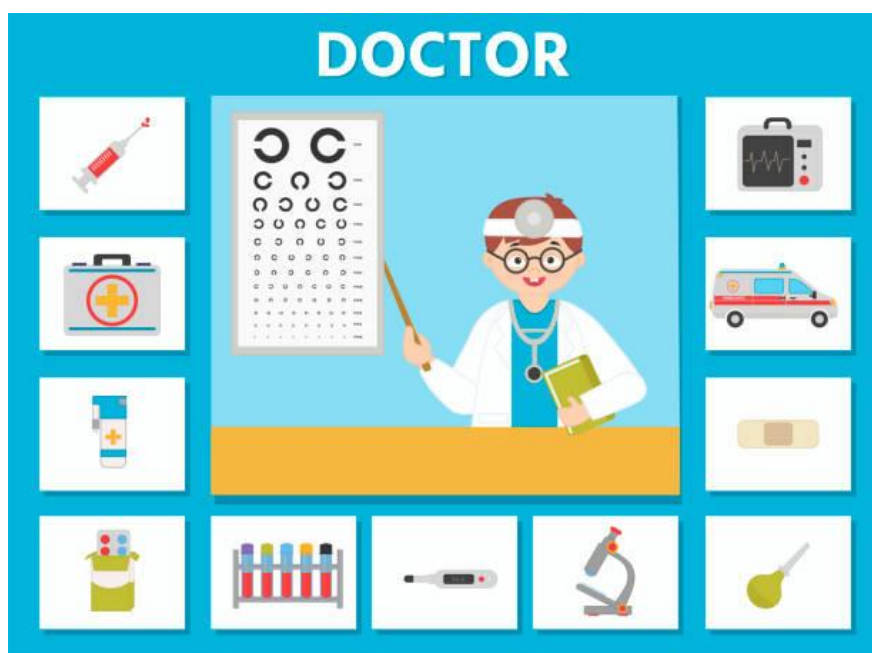


Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



 **MAŁOPOLSKA**

ROPS
KRAKÓW
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

 **FiRR**



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



 MAŁOPOLSKA


KRAKÓW
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO





Scenariusz zajęć nr 5: Temat: ZAKUPY

Uczestnicy: 8 osób (2 grupy po 4 osoby) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczestników WTZ

Czas zajęć: Materiał przygotowany na zajęcia może być realizowany na 2 (90 min) lub 3 godzinach lekcyjnych – zależnie od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć lub całego zespołu.

Cele kształcenia:

Cel ogólny:

- organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, uczestników WTZ na temat wizyty w sklepie spożywczym i robienia zakupów

- uświadomienie potrzeby robienia zakupów uzupełniania braków w produktach spożywczych, artykułach higienicznych i środkach czystości
- wyposażenie uczestników w takie umiejętności i wiadomości, które spowodują, że staną się oni świadomymi konsumentami
- przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwijanie i doskonalenie umiejętności społecznych.
- trening ekonomiczny

Cele szczegółowe:

- wyrobienie nawyku robienia listy zakupów, świadomego kupowania brakujących produktów, planowania codziennych posiłków
- dostrzeganie związku pomiędzy ilością gotówki jaką dysponuje dana osoba a możliwościami zakupowymi
- nauka planowania i gospodarowania domowym budżetem
- nauka porównywania produktów – wybór produktu w najkorzystniejszej cenie
- kształtowanie rozumienia możliwości kupowania, sprzedawania i płacenia za dane produkty
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niespodziewanych (np. brak danego produktu)
- ukazanie różnych sytuacji jakie mogą przydarzyć się podczas robienia zakupów (np. brak możliwości zapłacenia kartą, wybór za dużej ilości produktów w stosunku do posiadanej kwoty, brak umiejętności znalezienia określonego produktu)
- kształtowanie umiejętności społecznych (stosowanie form grzecznościowych, w razie potrzeby pomaganie innym, uważne słuchanie wypowiedzi komunikatów, nauka proszenia o pomoc)

- rozwijanie myślenia i bogacenie słownika za pomocą zabaw dydaktycznych
- poznanie wartości pieniądza
- wdrażanie do wykonywania czynności związanych z robieniem zakupów, wybieranie określonych produktów, proszenie o pomoc w wyborze asortymentu, umiejętność ważenia produktów, płacenie za wykonane zakupy

Cele operacyjne:

Uczestnik:

- umie prawidłowo zapłacić za zakupy (kartą lub gotówką)
- dostrzega związek pomiędzy ilością posiadanej gotówki a możliwościami zakupu produktów
- potrafi w razie potrzeby poprosić o pomoc obsługę sklepu
- wie w jaki sposób radzić sobie w nieprzewidywalnych sytuacjach (np. kiedy nie działa terminal płatniczy stosuje gotówkę)
- odpowiednio wybiera produkty, umie znaleźć pokrewne w razie braku pierwotnych (np. na liście znajdowała się sałata masłowa wybiera jej zamiennik)
- rozumie znaczenie uzupełniania zapasów spożywczych, chemicznych, higienicznych
- potrafi odpowiednio zarządzać domowym budżetem
- prawidłowo stosuje formy grzecznościowe
- potrafi umiejętnie przygotować i zrealizować listę zakupów (napisać- w przypadku uczestników z opanowaną umiejętnością pisaną, lub przygotować listę za pomocą symboli/obrazków/zdjęć)
- zna przebieg wizyty w sklepie oraz sytuacji zakupowych (wybór towaru na odpowiednich stanowiskach np. na stanowisku mięsny umie określić czego i ile potrzebuje)

Metody:

- podające: opis, pogadanka
- praktyczne: pokaz, ćwiczenia praktyczne, symulacje
- percepcyjne: obserwacja i pokaz, przykłady instruktora
- zajęcia z kartami pracy.

Formy pracy:

- indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne i pomoce do zajęć:

- ilustracje przedstawiające różne branże sklepów w tym np. (piekarnia, cukiernia, sklep mięsny, księgarnia itp.)
- prezentacja multimedialna,
- fotografie produktów
- plansze dydaktyczne dotyczące wybranych produktów spożywczych oraz działów na jakich można je znaleźć
- komputer z dostępem do Internetu

Pomoce dydaktyczne:

rzutnik multimedialny, koszyki z nazwą produktów, komputer, plastikowe owoce, warzywa, produkty higieniczne, chemiczne itp., kasa fiskalna, wózek zakupowy, monety i banknoty, portfel, siatki na zakupy,

Przebieg zajęć:

- I. Wprowadzenie do tematu:
 1. Piosenka na powitanie „Wszyscy są – witam Was”.

2. Prowadzący zapoznaje uczestników z tematem zajęć. Dyskusja na temat konieczności robienia zakupów. Jak przygotowujemy się do wyjścia do sklepów, co powinniśmy zabrać oraz gdzie udać się w celu ich wykonania.

3. Zabawa dydaktyczna pod kierunkiem prowadzącego „Gdzie możemy kupić wybrane produkty?” Na tablicy zostają przyklejone magnesami zdjęcia różnego rodzaju produktów spożywczych, chemicznych, higienicznych itp. Uczestnicy mają za zadanie dopasować odpowiedni produkt do sklepu bądź miejsca w sklepie w jakim może go znaleźć.

4. Słuchanie utworu Czesława Janczarskiego „Gdzie się co kupuje?” Prowadzący czyta tekst wiersza i prosi uczestników o uważne słuchanie, informuje ich, że po skończonym czytaniu będą musieli odpowiedzieć na kilka pytań.

Tekst utworu:

Mama poprosiła Anię, aby poszła do sklepu po chleb i syrop od kaszlu. Pieniądze położyła na stole, gdy Ania pobiegła do łazienki, żeby się umyć i uczesać Uszatek przechylił głowę na bok i pomyślał: „Wyręczę Anię”.

Wziął pieniądze ze stołu, wziął siatkę na zakupy i pobiegł do sklepu spożywczego. Stanął przed ladą.

-Poproszę o syrop od kaszlu- powiedział.

-Misiuniu- odpowiedziała pani zza lady- idź do apteki. O tam jest apteka, po przeciwnej stronie ulicy.

Pobiegł Uszatek do apteki. Stanął przy ladzie.

-Poproszę o chlebek- szepnął niepewnie

-Chlebek?- zdziwiła się pani sprzedająca leki. –Tu jest apteka, Misiuniu. Idź do sklepu spożywczego. O, tam jest ten sklep, po przeciwnej stronie ulicy.

Wyszedł Uszatek z apteki. Było mu bardzo przykro, że nie umiał wyręczyć Ani. Na ulicy spotkał Anię. Dziewczynka wybiegła zaraz za Uszatkiem.

-Oj, Misiu, Misu!- pokiwała głową

A potem wytłumaczyła niedźwiadkowi, gdzie się co kupuje.

Pytania do utworu:

- 1) O zakup jakich produktów poprosiła mama Anię?
- 2) Gdzie Miś chciał kupić chlebek?
- 3) W jaki sklepie Miś chciał kupić syrop na kaszel?
- 4) Czy Misiowi udało się wyręczyć Anię?
- 5) Jakie błędy popełnił Miś?

Zajęcia praktyczne:

Zabawa ruchowo naśladowcza – robimy zakupy!

Uczestnicy zajęć dzielą się na 4 grupy. Każda grupa dostaje do zrealizowania listę zakupów zawierającą różne produkty.

Zadanie numer 1.

Jak należy przygotować się do zrobienia zakupów.

Uczestnicy powinni zadbać o: siatkę, torbę na zakupy, posiadanie portfela z gotówką lub kartą płatniczą nie mogą również zapomnieć o wspomnianej wyżej przygotowanej liście.

Zadanie numer 2.

Uczestnicy planują do jakich sklepów muszą udać się aby kupić zapisane na liście zakupów produkty. W razie potrzeby nauczyciel koryguje odpowiedzi i naprowadza uczniów na poprawne rozwiązania.

Zadanie numer 3:

Uczestnicy udają się do sklepu i wykonują powierzoną listę, jeżeli zachodzi taka potrzeba powinni poprosić obsługę sklepu o pomoc, wybierają produkty z określonych działów sklepu lub różnych rodzajów sklepów dokonują zakupów udają się do kasy i płacą za zrobione zakupy. Na końcu chowają zakupy do przygotowanych wcześniej toreb, odbierają resztę i paragon.

Krótką odpowiedź jak należy zachować się w sklepie:

1. Po wejściu do sklepu przywitaj się słowami: „Dzień dobry”
2. Przygotuj listę zakupów i zorientuj się na jakich działach będziesz musiał dokonywać zakupów.
3. Wyszukaj potrzebne produkty i umieść je w koszyku/ wózku. W razie potrzeby poproś obsługę sklepu o pomoc.
4. Udaj się do kasy celem sfinalizowania zakupów.
5. Wyłóż wszystkie produkty na ladę.
6. Po skasowaniu przez ekspedientkę/ sprzedawcę wszystkich produktów zapłać za nie gotówką lub kartą płatniczą.
7. Po odebraniu reszty i paragonu spakuj swoje zakupy.
8. Podziękuj i pożegnaj się ze sprzedawcą.
9. Odniesź lub odłóż koszyk/ wózek w wyznaczone miejsce.

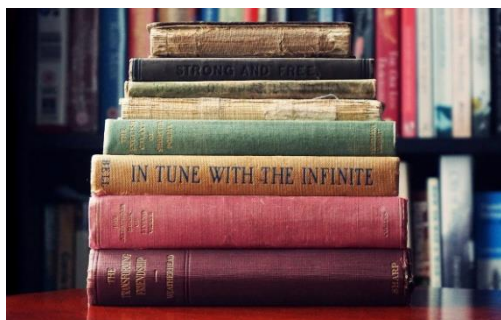
Zakończenie zajęć.

Podsumowanie informacji na temat zakupów spożywczych oraz wypełnienie karty zadań dotyczącej zakupów, możliwości płacenia oraz sytuacji jakie mogą zdarzyć się w sklepie.

Ankieta edukacyjna: ZAKUPY

Zadanie 1.

Dopasuj wybrany produkt do rodzaju sklepu, działu w którym będziesz mógł go zakupić.



*SKŁEP
KOSMETYCZNY*



CUKIERNIA



KWIACIARNIA



KSIEGARNIA



*SKŁEP
SPOŻYWCZY*



Zadanie 2.

Określ, czy wszystkie zdania są prawdziwe (zdania odczytuje prowadzący)

Zakreśl prawidłowe odpowiedzi (w przypadku uczestników piszących).

- | | |
|--|---------------|
| - W sklepie kosmetycznym zakupisz: chleb, bułki, drożdżówki. | PRAWDA/FAŁSZ |
| - Nabiał (mleko, ser, jajka) znajdziesz na dziale chemicznym. | PRAWDA/ FAŁSZ |
| - Na dziale mięsny kupisz wędlinę. | PRAWDA/FAŁSZ |
| - Po bukiet kwiatów udasz się do jubilera | PRAWDA/FAŁSZ |
| - Tort na urodziny zamówisz w cukierni. | PRAWDA/FAŁSZ |
| - Szampon do włosów znajdziesz na dziale z artykułami papierniczymi. | PRAWDA/FAŁSZ |
| - Owoce i warzywa kupisz w aptece. | PRAWDA/FAŁSZ |
| - Po gazetę udasz się do sklepu ogrodniczego | PRAWDA/FAŁSZ |

Zadanie 3 - Dla grupy posiadającej umiejętność liczenia lub używania kalkulatora

W Twoim portfelu znajduje się banknot 20 złotowy. Mama poprosiła Cię o zakupienie chleba, jajek i czekolady. Z poniższej listy produktów wraz z cenami ustal czy posiadana przez Ciebie kwota wystarczy Ci na zrealizowanie zakupów.

Produkt i kwota
Chleb 7 zł
Margaryna 5 zł
Ciastka czekoladowe 2,50 zł
Mleko 6 zł
Woda mineralna 2 zł
Jajka 8 zł
Makaron 4 zł
Jogurt 2 zł
Czekolada 3 zł
Chusteczki higieniczne 4 zł
Szampon 5 zł
Mydło 4 zł





Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



 **MAŁOPOLSKA**

ROPS
KRAKÓW
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

 **FiRR**

7. Wyniki testów, rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników

Innowacja została przetestowana w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębicy. Narzędzie testowało 8 uczestników WTZ. Są to osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym o niskim poziomie kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych, co stanowi dla nich przeszkodę w nawiązywaniu bliskich relacji i jest często przyczyną poczucia niższej wartości i osamotnienia.

Z tego powodu mają też ograniczoną możliwość przekazywania komunikatów w sytuacjach nagłych, wymagających pomocy lub interwencji innych, np. w czasie pogorszenia stanu zdrowia, doznania urazu, dostrzeżenia awarii.

Aby ograniczyć konieczność wykorzystywania pośrednictwa innych, opracowano narzędzie: aplikację „Go ahead – mów śmiało”, która służy rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych.

Spotkania z Testerami prowadziło czterech instruktorów terapii zajęciowej z WTZ w Dębicy. Miały one formę spotkań grupowych z wykorzystaniem scenariuszy tematycznych oraz indywidualne testowanie z wykorzystaniem aplikacji „Go AHEAD – mów śmiało”. Łącznie 6 godzin na jednego uczestnika.

Na wstępie przeprowadzono ankietę monitorującą dotyczącą poziomu motywacji Testerów do korzystania z narzędzia i ich umiejętności samodzielnej obsługi urządzenia z systemem android. Na zakończenie ponownie przeprowadzono ankietę, o takiej samej treści, celem obserwacji zmian w zakresie użytkowania aplikacji u członków grupy testującej.

Ankieta wstępna wykazała problemy u większości Testerów wynikające z braku wcześniejszego doświadczenia w korzystaniu z urządzeń IT. Trudność w obsłudze aplikacji wystąpiło zwłaszcza u osób z zaburzoną koordynacją ruchową i niską sprawnością manualną. Konieczne było wsparcie opiekuna i dłuższy czas na wykonanie zadania. Wszystkie osoby z grupy testującej chętnie uczestniczyły w zajęciach i zainteresowane były nowym narzędziem. Ankieta końcowa wykazała istotny postęp w zakresie posługiwania się urządzeniem z systemem android.

Tematem zajęć w ramach etapu testowania były różne sytuacje wymagające kompetencji społecznych i umiejętności komunikacyjnych:

- Radzenie sobie w sytuacji oparzenia
- Ruch drogowy
- Higiena osobista
- Zachowanie u lekarza
- Zakupy

Po zapoznaniu Testerów z zasadami działania aplikacji i omówieniu funkcji aplikacji, Uczestnicy rozwiązywali Quizy tematyczne sprawdzające i utrwalające ich wiedzę z omawianych zagadnień. Pomocą w aplikacji był film przed każdym z tematów z instrukcją postępowania przy obsłudze aplikacji i rozwiązywaniu testów.

Testerzy chętnie odpowiadali na pytania zadawane w poszczególnych częściach aplikacji. Zaskoczeni byli reakcjami narzędzia na udzieloną odpowiedź: zastosowaniem emotikon, które mimiką określały prawidłową lub negatywną reakcję/ odpowiedź na zadane pytanie. Niektórym uczestnikom w obsłudze narzędzia pomagali opiekunowie. Ich rolą było przeczytanie polecenia/pytania lub pomoc w kolejnych krokach aplikacji wprowadzających do kolejnego tematu.

Testy sprawdzające przeprowadzone przed przystąpieniem do testowania aplikacji wykazały deficyty informacji w zakresach wiedzy dotyczących sytuacji testowanych w aplikacji. Szczególne deficyty z zakresu higieny dotyczyły właściwego dbania o jamę ustną i zęby, prawidłowego mycia ciała i rąk. Większość Testerów z tematu o oparzeniach nie znała właściwej reakcji na oparzenia i nie potrafiła podać numerów alarmowych w nagłych sytuacjach. Niektórzy mieli trudność z określeniem, w jakich działach w sklepie kupuje się określone towary. Nie uwzględniali również możliwości robienia zakupów z wykorzystaniem karty płatniczej.

W zakresie bezpieczeństwa na drodze Testerzy dopuszczali przechodzenie przez ulicę mimo braku pasów dla pieszych i nie potrafili podać procedury przechodzenia przez jezdnię.

W temacie dotyczącym wizyty u lekarza i dbałości o zdrowie Testerzy dopuszczali w większości możliwość stosowania leków bez konsultacji z lekarzem. Nie znali nazw

specjalizacji lekarzy i nie potrafili podać numeru alarmowego pogotowia ratunkowego. Prowadzone zajęcia i spotkania przeprowadzone z użyciem aplikacji w zdecydowanej większości wzbogaciły wiedzę i zasób słownictwa osób testujących. Testowanie aplikacją wzbogaciło i utrwaliło ich wiedzę w sprawdzanych obszarach. Świadczyły o tym wyniki testów przeprowadzonych na ostatnich zajęciach i opinie Opiekunów prowadzących testowanie aplikacji.

Opierając się na wynikach obserwacji prowadzonych przez Opiekunów, podsumowując realizację innowacji i opracowania narzędzia można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Korzyścią aplikacji „Go ahead – mów śmiało” jest przyrost wiedzy i słownictwa u Testerów.
2. Możliwość korzystania z aplikacji na telefonie, który jest urządzeniem bardzo atrakcyjnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększa motywację do wzbogacania wiedzy, nawet gdy proponowane w aplikacji informacje nie zawsze mieszczą się w obszarze zainteresowań Testerów. Korzystanie z telefonu wpłynęło na zwiększenie ich zaangażowania w wykonywanie zadań, niwelowało zniechęcenie pojawiające się zazwyczaj przy konieczności czytania tekstów.
3. Samodzielność Testerów w posługiwaniu się aplikacją (obsługa aplikacji) uzależniona jest od poziomu sprawności czytania i rozumienia przeczytanych komunikatów.

Przy wykorzystywaniu narzędzia przez osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną niezbędna jest pomoc opiekuna przy logowaniu się do aplikacji i jej obsłudze z powodu niedostatecznie opanowanej u niektórych osób techniki czytania ze zrozumieniem.

Rekomendacje:

1. Wykorzystanie aplikacji na telefon podczas edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną zwiększa atrakcyjność procesu nabywania wiedzy czy umiejętności, więc warto ten rodzaj przekazu zastosować w edukacji dotyczącej różnych dziedzin codziennego życia, co korzystnie może wpłynąć na poprawę zaradności życiowej i zmniejszenie potrzeby wsparcia ze strony innych, odciążając otoczenie z konieczności opieki.

2. Umiejętność korzystania z telefonu i obsługi aplikacji ma wpływ na poprawę samooceny i poczucia wartości Testerów: wzrost sprawczości, niezależności, samodzielności, a także wzrost motywacji do zdobywania wiedzy i poszerzania swojej niezależności.
3. Korzystanie z aplikacji telefonicznej powoduje poprawę w poczuciu przynależności niepełnosprawnych, zmniejsza odczucie wykluczenia społecznego.
4. Korzyścią aplikacji dostrzeżoną na etapie testowania była niewielka ilość pytań w poszczególnych Quizach o zróżnicowanej tematyce, co zapobiegało rozproszeniu uwagi, znużeniu i zmęczeniu psychicznemu u osób z zaburzoną koncentracją uwagi, które zaobserwowano w dłuższych zajęciach prowadzonych metodą tradycyjną, z wykorzystaniem scenariuszy tematycznych.
5. Biorąc pod uwagę opinię Testerów narzędzie może posłużyć rozwijaniu kompetencji społecznych z innych dziedzin: zgłaszano zainteresowanie nabycia poprzez aplikację wiedzy w zakresie: zachowania w klubie fitness, możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad zdrowego żywienia.

Narzędzie, jak się okazało w czasie testowania ma jednak pewne ograniczenia.

1. Aplikacja, w pełni samodzielnie, może być wykorzystywana tylko przez osoby z opanowaną techniką czytania ze zrozumieniem i posiadającym telefon z systemem android.
2. Niektóre osoby testujące miały trudność w zrozumieniu pojęć dla nich abstrakcyjnych takich jak: aplikacja, logowanie, login itp. Dla niektórych z osób konieczne było indywidualne wsparcie Opiekuna, zwłaszcza na etapie wdrażania do obsługi urządzenia. Dlatego wskazane jest przeprowadzenie zajęć wprowadzających bogacących wiedzę w tym zakresie.
3. Korzyścią dla aplikacji byłoby zastosowanie przekazu w formie obrazków, animacji, filmików, co ułatwiłoby odbiór treści.
4. Wydaje się, że korzyścią dla aplikacji byłoby stosowanie krótszych komunikatów lub komunikatów obrazkowych oraz odpowiedzi w formie potwierdzająco- przeczącej: TAK /NIE.
5. Zgłaszanym postulatem było większe pogłębienie jednego – dwóch tematów (dokładniejsze omówienie) przy ograniczeniu ilości omawianych zagadnień.

Dobrym rozwiązaniem byłoby skonsultowanie z odbiorcami tematów/obszarów kolejnej aplikacji. Takie rozwiązanie dałoby im poczucie sprawstwa, współtworzenia narzędzia.

6. Aplikacja daje możliwość korzystania, powtórzenia w warunkach domowych

7. Istotnym problemem dostrzeżonym na etapie testowania było zapominanie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną hasła lub adresów mailowych. Rozwiązaniem mogłaby być możliwość logowania z imienia lub przy użyciu znaku graficznego.

8. Podsumowanie.

Podczas testowania aplikacji „Go AHEAD – mów śmiało” okazało się, że aplikacja jest atrakcyjnym narzędziem edukacyjnym dającym możliwość urozmaicenia zajęć kształtujących kompetencje społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym umiejętności komunikacyjne. Jest narzędziem zachęcającym i motywującym do zdobywania wiedzy w danej, wybranej dziedzinie. Przynosi radość i satysfakcję z uzyskanych wyników. Mając na uwadze duże zaangażowanie i zainteresowanie narzędziem w grupie testującej i postępy Testerów w zakresie komunikatywności i umiejętności społecznych można stwierdzić także, że aplikacja „Go AHEAD – mów śmiało” obok walorów edukacyjnych, może być polecana jako narzędzie niwelujące wykluczenie technologiczne osób z niepełnosprawnością intelektualną.